

Introduction Psychiatrie – Conus

- ▶ Les troubles psychiatriques sont **fréquents**
- ▶ Ils commencent en majorité chez les **jeunes**
- ▶ Ils ont un **grand impact** sur le fonctionnement (proportion importante de l'invalidité dans les **pays "surdéveloppés"**) → Il est nécessaire d'agir pour changer cet état de fait :
 - ▶ Améliorer les traitements
 - ▶ Améliorer l'intégration des patients
 - ▶ **CHANGER DE STRATEGIE** : Intervention précoce, interventions de prévention, information dans la population
- ▶ TROP de patients n'accèdent pas aux soins et **"Treatment Gap"** → **Troubles psychiatriques** n'ayant pas reçu de **TT** au cours des 12 derniers mois :
 - ▶ Pays développés : 35.5 à 50.3 %
 - ▶ **Pays en voie de développement** : 76.3 à 85.4 %)
- ▶ Il existe plusieurs approches thérapeutiques
- ▶ Ces traitements sont **très efficaces**
- ▶ Les **nouvelles approches** d'intervention précoce sont prometteuses
- ▶ La **recherche** est nécessaire pour améliorer les traitements

Les 10 causes principales d'invalidité

Males			Females		
Cause	YLD (millions)	Per cent of total YLD	Cause	YLD (millions)	Per cent of total YLD
1 Unipolar depressive disorders	24.3	8.3	1 Unipolar depressive disorders	41.0	13.4
2 Alcohol use disorders	19.9	6.8	2 Refractive errors	14.0	4.6
3 Hearing loss, adult onset	14.1	4.8	3 Hearing loss, adult onset	13.3	4.3
4 Refractive errors	13.8	4.7	4 Cataracts	9.9	3.2
5 Schizophrenia	8.3	2.8	5 Osteoarthritis	9.5	3.1
6 Cataracts	7.9	2.7	6 Schizophrenia	8.0	2.6
7 Bipolar disorder	7.3	2.5	7 Anaemia	7.4	2.4
8 COPD	6.9	2.4	8 Bipolar disorder	7.1	2.3
9 Asthma	6.6	2.2	9 Birth asphyxia and birth trauma	6.9	2.3
10 Falls	6.3	2.2	10 Alzheimer and other dementias	5.8	1.9

Nosologie

- La NOSOLOGIE (du grec nosos = maladie) est une branche de la médecine qui étudie les **critères de classification** des maladies
- C'est principalement sur la base de la présence de certains symptômes que se pose le diagnostic
- Selon les divers modèles explicatifs existants, les cliniciens ont développé de multiples diagnostics mêlant symptômes et contexte
 - Dépression réactionnelle
 - Bouffée délirante aigüe
 - Délire passionnel de Clérambault
- Multiples différences d'interprétation des divers diagnostics
- Nécessité de développer une classification claire et unifiée
- DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) classe des **"troubles"** ou **entités syndromiques** (et non des maladies, vu que les mécanismes sont inconnus)
 - Approches par catégories
 - Catégories définies par la présence de certains symptômes
 - Il faut la présence d'au moins un certain nombre de symptômes pour remplir les critères de diagnostic
- ▶ En psychiatrie le diagnostic est utile mais beaucoup moins déterminant que dans les autres branches de la médecine. Une fois le diagnostic posé, tout reste à faire :
 - ▶ Comprendre le contexte d'apparition des symptômes
 - ▶ Intégrer ce contexte dans la trajectoire existentielle du patient
 - ▶ Créer un climat de confiance
 - ▶ Décider avec le patient qu'elle va être la stratégie
- ▶ L'objectif est de comprendre la situation et de conduire le patient vers un nouvel état d'équilibre par le biais de diverses interventions bio-psycho-sociales
- ▶ Le DSM ou la CIM ne sont donc **pas** des manuels de psychiatrie, mais seulement des guides pour le diagnostic

Les modèles de compréhension en psychiatrie

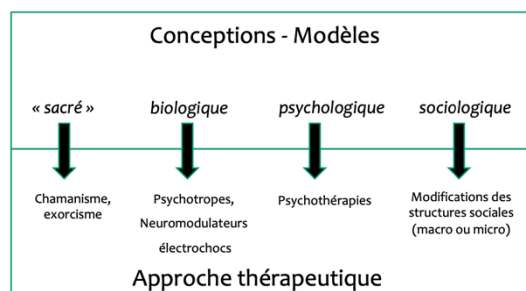
- ▶ Plusieurs modèles de compréhension existent, ils sont en évolution constante, du fait que les mécanismes qui sont à la base de la vaste majorité des troubles psychiatriques restent inconnus.
- ▶ Les modèles explicatifs principaux sont :

1) Modèle du sacré

- Renvoie à des notions de faute, de possession, ou d'élection divine. Beaucoup de femmes ont été brûlées sous prétexte de sorcelleries mais avaient sûrement des psychoses (Jeanne d'arc)
- Peu présent dans les conceptions contemporaines des soignants en Occident
- Par contre, présent chez passablement de patients ou de leurs proches, particulièrement en psychiatrie transculturelle
- Est probablement au fondement des processus de stigmatisation des maladies mentales, et de la culpabilité qui pèsent sur les proches
- Très important de se préoccuper des convictions religieuses des patients

2) Modèle biologique

- Dans sa forme "extrême" :
 - Toutes les manifestations du psychisme (émotions, pensées, sentiments, actions, ...) peuvent être réduites à des mécanismes physiologiques du SNC



- Les pathologies psychiatriques sont donc liées à des dysfonctionnements du cerveau (problèmes de neurotransmetteurs, de connexions intracérébrales, de récepteurs synaptiques...)
- Les diagnostics pourraient se poser sur la base de l'identification de ces mécanismes
- Quelques exemples justifiant cette hypothèse :
 - **Psychose** liée à excès de dopamine
 - **Dépression** liée à déficit en sérotonine
 - **Symptômes psychotiques** (hallucinations, délire) possible en cas de fièvre ou en cas d'absorption de certaines substances (cannabis, LSD...)
 - OH modifie le comportement
 - Certaines lésions cérébrales modifient le comportement et engendrent divers symptômes psychiatriques
- Bien qu'il soit difficile d'accepter ou de concevoir que ce qui fait notre âme puisse n'être que le résultat de l'action de neurotransmetteurs sur des récepteurs, le développement de la psychiatrie biologique et donc des médicaments a transformé la pratique de la psychiatrie
 - Les patients ont pu être détachés
 - Ils ont pu retourner dans la communauté
 - Leurs pensées ont été clarifiées
 - La psychothérapie est devenue accessible à tous les patients, quel que soit le trouble dont ils souffrent

3) **Modèle sociologique**

- Ce sont les conditions sociales (collectives et/ou individuelles) et elles seules qui définissent la déviance, ou qui conduisent l'individu à la déviance
- Les "fous" sont les sages d'une société malade
- De nombreuses enquêtes épidémiologiques ont démontré le rôle de facteurs sociaux comme élément contributifs déterminants à l'émergence de troubles mentaux (p.ex : acculturation, émigration, chômage, genre, exposition au milieu urbain)
- Certaines pathologies ont des prévalences très différentes d'une culture à l'autre (p.ex : la boulimie ou l'anorexie)
- Certaines pathologies « émergent » dans des conditions sociologiques données (p.ex : « burn-out », mobbing)
- Importance des aspects culturels dans la manifestation des troubles psychiatriques
- Les manifestations de certains troubles psychiatriques s'exacerbent dans le contexte de conflits familiaux, et se résolvent dans le cadre d'interventions dites systémiques

4) **Modèle psychologique**

- CONCEPT DE BASE :
 - Notre psychisme est composé d'une structure de base (de solidité variable selon les sujets) et d'outils qui nous permettent de nous adapter à notre environnement
 - Ces capacités d'adaptation peuvent être dépassées dans divers contextes d'exposition à des facteurs de stress ou à des traumatismes
 - Quand les capacités d'adaptation sont dépassées, nos perceptions et nos comportements peuvent être altérés : nous « produisons » des symptômes

Il existe trois modèles principaux de conceptualisation de l'organisation de notre système psychique. Ils sont à la base des trois grands axes de méthodes de psychothérapie reconnus par la FMH :

a. **Le modèle psychanalytique** (Freud)

- Ce modèle se réfère à la fois :
 - À une conception du psychisme humain et
 - À un **modèle de soins, la psychanalyse** (qui doit favoriser l'accès à l'inconscient du patient)
- CONCEPT DE BASE :
 - Le psychisme comprend trois instances :
 - **Ça** (siège de l'inné, des pulsions)
 - **Moi** (siège de la décision)
 - **Surmoi** (siège de l'acquis et des interdits (morale, lois))
 - Un système de pulsions :
 - Eros (libido) et Thanatos (pulsion de mort)
 - Des mécanismes dynamiques d'adaptation (mécanismes de défense)
- CONFLIT INTERNE ET MÉCANISMES DE DÉFENSE :
 - Les pathologies psychiques sont la manifestation de **conflits internes** entre
 - Les pulsions émanant du ça
 - La pression de contrôle du surmoi
 - Le nécessité de décision du moi
 - Face à l'angoisse, mobilisation de **mécanismes de défense** garantissant l'équilibre du moi, de manière plus ou moins économique
 - Exemples : Humour, intellectualisation, refoulement, déni, projection paranoïaque
 - Selon l'intensité du stress, recours à des mécanismes de plus en plus archaïques (déni, paranoïa...)
- Les thérapies « psychodynamiques » (qui découlent de la psychanalyse et du modèle psychanalytique) s'articulent sur les principes suivants :
 - L'exposition à des traumatismes (infantiles) dépasse les capacités des mécanismes de défense à faire face au stress qui en découle
 - Il faut remonter à ce traumatisme initial (par les associations libres qui laissent remonter à la conscience des souvenirs refoulés et devenus inconscients)

- La compréhension de ce traumatisme permet
 - L'intégration/compréhension de cet événement
 - L'assouplissement des mécanismes de défense chronifiés
 - L'assouplissement du surmoi

b. Le modèle systémique (Bateson et Watzlavick)

- **CONCEPT DE BASE :**
 - Modèle rattaché au modèle sociologique de la maladie mentale : le milieu influence l'individu qui manifeste les symptômes d'un système malade
 - S'est développée sur la base de théories de physique et de cybernétique qui démontrent que les propriétés d'un corps sont influencées par les corps qui l'entourent
 - Concept repris par les psychanalystes qui réalisaient l'importance de prendre en compte les influences extérieures (et surtout familiales) dans la prise en charge des patients
 - Les composants d'un système familial et/ou social interagissent
 - On ne peut pas connaître et aider un individu sans considérer le système dans lequel il vit (famille, cercle social)
 - En psychiatrie, le concept de système peut s'appliquer non seulement à la famille, mais également aux différents « réseaux » dans lesquels le patient est inséré et dont il faut tenir compte
 - Mise en place d'intervention systémiques dans le cadre desquelles on considère que le patient est en fait le « patient désigné » par le système
 - Le patient désigné est celui qui manifeste les symptômes du système malade
 - Hypothèse : en intervenant sur le système malade, le patient désigné va s'améliorer et les symptômes vont disparaître
 - Thérapies familiales
 - Thérapies de couple
 - Souvent thérapies combinées : individuelle et systémique

c. Le modèle cognitivo-comportementaliste (Pavlov et Beck)

- **COGNITION :** Ensemble des activités psychologiques de traitement de l'information fournie par les sens et d'acquisition de connaissance
- **CONCEPT DE BASE :**
 - Se développe à partir des travaux sur le conditionnement :
 - On observe que l'on peut créer des comportements réflexes chez les animaux
 - On en déduit l'existence de schémas de pensée pour traiter l'information, schémas qui se renforcent progressivement au cours de la vie
 - De la peur dans un ascenseur à la phobie des ascenseurs
 - De l'interprétation des événements à la paranoïa
 - Certains de ces schémas sont dysfonctionnels qui conduisent aux pathologies :
 - Lecture toujours négative des événements : dépression
 - Interprétations centrées sur soi des événements : paranoïa, délire
 - On imagine alors la possibilité de modifier les schémas de comportement
- **Thérapie cognitive :** vise les modifications pathologiques du traitement de l'information (biais d'interprétation, schémas défavorables)
- **Thérapies comportementales :** désapprentissage de symptômes et de comportements pathologiques (déconditionnement, désensibilisation par immersion)
- **Le modèle TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale) :** Approches se basant sur ces deux aspects
- ▶ Il existe encore des puristes mais la psychiatrie moderne prône la mixité et la complémentarité de trois de ces modèles (le modèle du sacré étant abandonné des approches contemporaines)
 - ▶ On traite la dépression en combinant médicaments et approches psychothérapeutiques
 - ▶ Consensus sur un modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL des troubles psychiatriques
- ▶ Le poids donné à l'un ou l'autre des modèles
 - ▶ Varie d'un thérapeute à l'autre
 - ▶ Dépend de la situation
 - ▶ Dépend de la préférence du patient
- ▶ Il est important de prendre en compte le modèle explicatif du patient de manière à s'adapter à ses besoins
- ▶ Selon la conception que l'on a de la maladie mentale, les modèles et les approches thérapeutiques varient

Principaux syndromes psychiatriques (adulte)

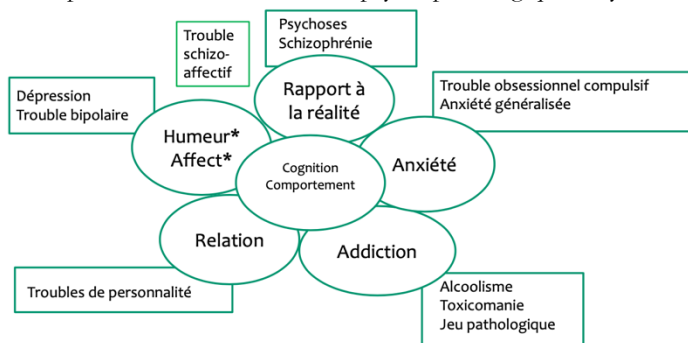
Sémiologie

- **SEMILOGIE :** science médicale qui étudie les signes et les symptômes des maladies
 - En médecine somatique, la distinction est claire entre :
 - Symptômes (ce que le malade dit ressentir, ce qu'il raconte de son état)
 - Signes (éléments objectivés par l'examen médical ; tension artérielle, souffle cardiaque...)
 - En psychiatrie, cette distinction est plus floue et les deux aspects de l'investigation se passent en même temps
 - Exemple : la tristesse du patient déprimé se retrouve dans ce qu'il raconte de son état mais se voit également sur son visage et son attitude

- La sémiologie s'évalue dans le cadre d'une relation interpersonnelle qu'il faut savoir créer, la qualité de l'évaluation dépendant de la qualité du contact
- On prend également en compte ses propres réactions (parfois inconscientes) pour construire le diagnostic :
 - Irritation, ennui, compassion tristesse, malaise...
- LIMITE ENTRE NORMAL ET PATHOLOGIQUE :
 - Pour de nombreux traits de la vie psychique, la limite entre ce qui est normal et ce qui est pathologique n'est pas claire
 - Difficile de fixer un seuil quantitatif normal pour les émotions
 - Exemple de la tristesse :
 - Réactions plutôt normales : « C'est trop triste, la neige est pourrie... » « Je suis très triste parce que mon grand-père est décédé hier soir. »
 - Réactions plutôt pathologiques : « Depuis quatre mois que j'ai dû aller vivre à Glasgow pour mon travail, je me sens triste tous les soirs et je n'ai même pas envie de regarder la TV. » « Depuis que j'ai perdu mon emploi, je me sens triste, j'ai l'impression de ne rien valoir, je n'ai pas l'énergie pour rechercher un travail, je mange peu, et je me réveille toutes les nuits vers 4 heures du matin. J'ai parfois des envies de suicide. »
 - Le caractère pathologique ou non d'une manifestation doit être déterminé en fonction :
 - Du contexte relationnel et culturel dans lequel cette manifestation apparaît
 - De la souffrance que cette manifestation induit chez l'individu ou chez ses proches (voire dans la société)
 - De l'impact que cette manifestation a sur le fonctionnement de la personne
 - De son apparition au sein d'un ensemble syndromique de manifestations
 - Parfois il est difficile de savoir si ce que raconte le patient est basé sur la réalité ou sur une perception délirante :
 - Besoin de l'information des proches ou d'éléments de réalité

Signes et symptômes en psychiatrie

Principaux domaines d'évaluation psychopathologique et syndromes psychiatriques associés :



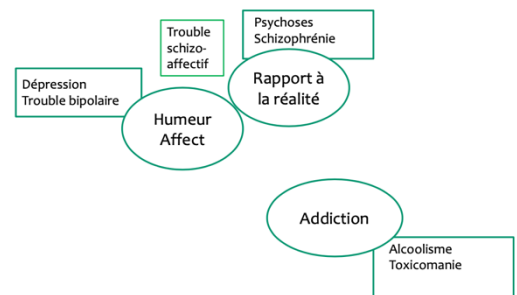
❖ L'humeur se rapporte à un état émotionnel global et durable (« climat »),
❖ L'affect se rapporte à des modifications et à des fluctuations de l'état émotionnel (le « temps » qu'il fait).

- ▶ Les symptômes ne sont pas propres à un seul diagnostic (comme la fièvre pour les pathologies infectieuses et tumorales)
- ▶ **Dépression** rencontrée dans
 - ▶ Les troubles **dépressifs**
 - ▶ Les troubles **bipolaires**
 - ▶ La **schizophrénie**
- ▶ **Symptômes psychotiques** se voient dans
 - ▶ La **schizophrénie** (caricaturalement)
 - ▶ Les troubles **dépressifs**
 - ▶ Les troubles **bipolaires**
 - ▶ Les troubles **organiques**

1) Troubles psychotiques

a. DEFINITION

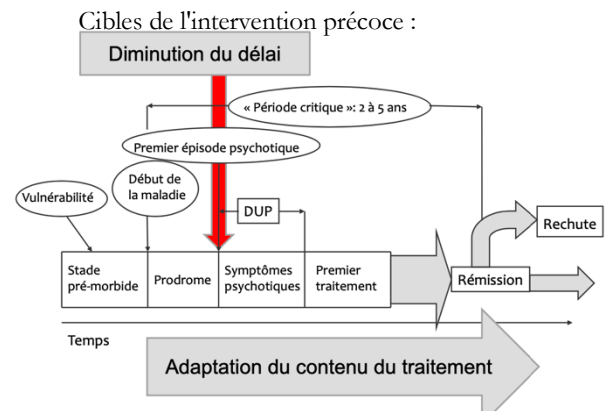
- **PSYCHOSE** : Perte de contact avec la réalité
 - Survenue de troubles de la pensée, émotionnels, perceptifs, et/ou du comportement liés à une perte de contact avec la réalité
 - CIM 10 : Terme descriptif sans référence théorique à des mécanismes psychopathologiques, utilisé simplement pour indiquer la présence de
 - *Hallucinations* et/ou
 - *Idées délirantes* et/ou
 - *Désorganisation de la pensée* et/ou
 - *Comportements anormaux*
 - Symptômes observables dans diverses catégories diagnostiques rassemblées sous le terme de **Troubles psychotiques** :
 - **Psychoses affectives**
 - **Psychoses non-affectives**
 - **Trouble schizo-affectif**
 - Leur seule présence ne permet pas de poser un diagnostic précis → **DD** :
 - **Intoxication aiguë par des drogues**
 - **Trouble organique**
 - **Trouble de personnalité**
 - **PTSD**
 - Maladie de "jeunes" :
 - 70% des **psychoses** émergent entre 18 et 35 ans
 - 65% des **tr bipolaires** émergent avant 18 ans
 - L'adolescence est une période difficile de la vie avec plusieurs défis :
 - Définition de son identité
 - Émancipation du milieu familial



- Finalisation de son éducation
- Choix de trajectoire
- Construction d'un réseau social
- Expérience de relation intime

b. INTERVENTION PRECOCE

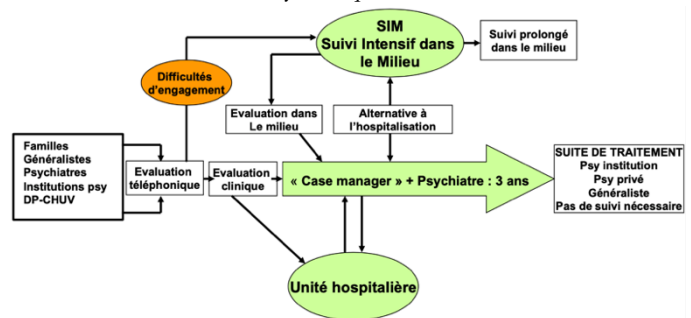
- La grande majorité des patients souffrant de psychose accèdent au **traitement beaucoup trop tard** :
- **Long DUP** (Duration of Untreated Psychosis) (délai entre apparition des symptômes et début du traitement) a un **impact néfaste** :
 - Suicide (15% tentative avant traitement)
 - Moins bonne réponse au traitement
 - Mauvaise évolution fonctionnelle
 - Développement de comorbidités
 - Impact socio-économique
 - Détresse des parents et de leurs proches
- Les **divers stades** de la maladie nécessitent des traitements spécifiques
- **Période critique** de 3 à 5 ans
- Patients souvent **difficiles à approcher** :
 - Volonté d'indépendance et d'émancipation
 - Peu d'expérience des systèmes de soin
 - Stéréotypes négatifs à l'égard de la maladie mentale
 - Foi en leur propre invulnérabilité
 - Difficultés à accepter le besoin de traitement
 - Crainte de l'hospitalisation
 - Se méfient des psychiatres
 - Ne veulent pas être pris pour des fous
- **Deux réactions fréquentes** après un premier épisode psychotique :
 - Le **désengagement** (< 50% se rendent au 1^{er} rendez-vous ambulatoire après une première hospitalisation)
 - Le **déni**
- Patients bien plus ouverts pendant la phase prodrome
- Ne pas attendre la chronicité pour soigner
- Proposer des soins spécifiques et efficaces
- Avoir une approche ambitieuse et optimiste
- Le **désengagement** : Favoriser l'engagement des patients :



1. Organiser des soins accessibles

• **Programme TIPP** : Traitement et Intervention dans la phase Précoce des troubles Psychotiques

- Rôle et missions :
 - Engagement des patients / partenariat
 - Continuité des soins
 - Information des patients et de leurs proches
 - Rôle psychothérapeutique
- Infirmier, assistant social, psychologue
- Fil rouge de la prise en charge pendant 3 ans
- Prise de contact très précoce (en cours d'hospitalisation, à domicile, chez le médecin installé)
- Nombre limité de patients (~35)
- Peut se déplacer à domicile ou dans le milieu (2x/sem)
- Fait équipe avec le médecin psychiatre
- → **Désengagement : 7%**
- Critère d'inclusion :
 - 18-35 ans
 - Trouble psychotique
 - < 6 mois de traitement pour le trouble psychotique (exceptions pour les patients en pédopsychiatrie)
 - Domicile secteur centre (330'000 habitants)
- 45-55 nouveaux patients par an
- Plus de 850 patients prise en charge dans le programme depuis sa création en 2004



2. Favoriser l'engagement dans les soins

- Garantir la continuité des soins
- Adapter l'intervention au stade de conceptualisation du patient
- Explorer les expériences préalables de traitement
- Prendre le temps de comprendre la personne dans son ensemble plutôt que de ne se focaliser que sur les symptômes
- Explorer les ressources et les projets, pas seulement les déficits
- Identifier les priorités du patient
- Comprendre le modèle explicatif du patient
- Soutenir l'optimisme réaliste
- Être prêt à faire face à des ruptures qui peuvent aussi permettre des expériences et à terme renforcer l'alliance
- L'engagement est un processus progressif : être persévérant

- Se laisser toucher par l'histoire du patient
- **3. Identifier les patients les plus à risque de désengagement = Prévenir la rupture**
 - Facteurs prédictifs de rupture : (25% de rupture sur 18 mois)
 - Passé judiciaire (OR = 1.7)
 - Absence de liens avec la famille (Or = 1.7)
 - ENGAGEMENT DES FAMILLES DANS LE TRAITEMENT
 - Évaluations et entretiens
 - Approche systématique
 - GROUPE MULTIFAMILIAL SUR LA PSYCHOSE DEBUTANTE
 - 4 sessions
 - Familles de patients récemment entrés dans le programme
 - Focus sur la phase précoce des psychoses
 - LE TRIANGLE : Séance d'interaction-information Patient - Proches - Soignants
 - PROGRAMME PRO-FAMILLE : 16 sessions multifamiliales pour les proches de patients souffrant de *schizophrénie*
 - Persistance d'abus de substance (OR = 2.3)
 - >50% des patients
 - Le plus fréquent : Cannabis
 - Une intervention brève est plus efficace que pas d'intervention du tout
 - Adapter le traitement au degré de motivation
 - La limitation des risques est souvent un objectif plus réaliste que l'abstinence complète
 - Un premier épisode psychotique : facteur de motivation, fenêtre d'opportunité
 - Favoriser les approches motivationnelles
- Le **déni** : Favoriser le développement de l'insight
 - Conséquences positives de l'insight :
 - Diminue le risque d'agir les *idées délirantes*
 - Facilite l'établissement d'une relation thérapeutique
 - Permet de meilleures relations avec la famille
 - Insight et adhérence au traitement médicamenteux :
 - Corrélation modérée entre présence d'insight et adhérence au traitement médicamenteux
 - Mais, présence possible d'une bonne adhérence à la médication SANS insight
 - Adhérence à la médication est aussi liée à d'autres éléments : confiance, qualité de la relation thérapeutique, effets secondaires, effet des médicaments sur certains éléments de la psychopathologie comme l'anxiété...
 - Les patients dotés d'insight ont une meilleure évolution symptomatique et fonctionnelle
 - Conséquences négatives de l'insight :
 - Un certain degré d'absence d'insight fait partie de la norme...
 - Un certain degré de déni peut avoir un effet protecteur
 - L'insight peut parfois aggraver les choses : « adding insight to injury »
 - Dépression post psychotique :
 - Survient chez 25% des patients
 - Est significativement liée à la présence d'insight
 - Est plus fréquent chez les patients qui tendent à un processus d'intégration de l'épisode que chez ceux qui utilisent le déni défensif
 - L'**insight** ↗ aussi le risque d'auto-stigmatisation et d'identification au rôle de malade
 - ▶ A manier avec prudence et finesse
 - **Approches thérapeutiques du déficit d'insight** :
 - Principe de base :
 - Écouter le patient
 - Entendre sa conception de ce qui lui arrive
 - Définir des objectifs qui lui conviennent
 - Ne pas directement remettre en question le déni
 - Explorer/chercher à comprendre le contenu du *délire*
 - Identifier les facteurs de crise
 - Faire preuve de flexibilité
 - Accepter insight partiel...
 - Accepter les variations du degré d'insight
 - Processus interactif de construction d'une compréhension de soi
 - La phase d'exploration est elle-même une phase de psychothérapie
 - L'insight n'est pas un but en soi : ce qui est un but c'est de prévenir les mises en danger et de viser à aider le patient à retrouver un équilibre qui **lui** convienne
- ▶ Un premier épisode de psychose peut avoir un impact majeur sur la vie des patients
- ▶ Le désengagement des soins et le déni de la maladie sont des réactions habituelles chez les jeunes patients
 - ▶ L'**engagement** peut être renforcé par
 - ▶ L'organisation des services (case management assertif)
 - ▶ Des approches d'engagement spécifiques
 - ▶ La prévention des facteurs de désengagement (abus de substance et inclure les familles)
 - ▶ Le **développement de l'insight** est un processus thérapeutique

- ▶ Une fois le patient engagé, plusieurs stratégies sont disponibles pour promouvoir le rétablissement
- ▶ **Il est important de promouvoir la réorganisation de services de psychiatrie, les programmes de soins spécialisés pour les troubles émergents et de proposer des formations adéquates considérant leur impact sur ces éléments**
- ▶ Les **INTERVENTIONS PRECOCES** sont plus efficaces et plus économiques sur le long terme

c. SEMIOLOGIE PSYCHOTIQUE

4 domaines de la symptomatologie psychotique :

1. *Délire* (ou idées délirantes)

Le délire naît sur fond de modification générale du vécu et se manifeste par une appréciation erronée de la réalité

- Systématisé ou non
- A différencier suivant le contenu
 - Mystique, de persécution, de ruine, hypocondriaque, de grandeur, de référence
- Conviction absolue mais erronée
- Irréductible par la logique et l'évidence des faits
- Qui n'est pas expliquée par l'appartenance à un groupe culturel et par le partage de croyance propres à ce groupe
 - Classification par rapport au **contenu** :
 - *De persécution* ou *paranoïde*
 - *Mystique*
 - *De ruine*
 - *De grandeur*
 - *De référence*
 - Classification par rapport à la **cohérence** :
 - *Bizarre*
 - *Systématisé*
- Peut se concevoir comme une erreur d'interprétation de la réalité

2. *Hallucinations* (Troubles des perceptions)

- Perceptions par une voie sensorielle alors qu'il n'y a pas de stimulus
 - *Auditifs*
 - *Visuels*
 - *Cénesthésiques*
 - *Olfactifs*
 - *Gustatifs*
- Perception sans objet, pouvant toucher toutes les modalités sensorielles
 - **Hallucinations auditives** : les plus fréquentes (60- 70 % patients schizophrènes)
 - Les plus caractéristiques dans la schizophrénie :
 - Voix à la III^e personne
 - Formulant des commentaires sur le comportement du patient
 - Proférant des insultes
 - Ou plusieurs voix conversant entre elles
 - **Hallucinations visuelles** : 10 % patients
 - **Hallucinations olfactives** : plus fréquentes dans l'épilepsie temporale
 - **Hallucinations cénesthésiques**
 - **Hallucinations gustatives**

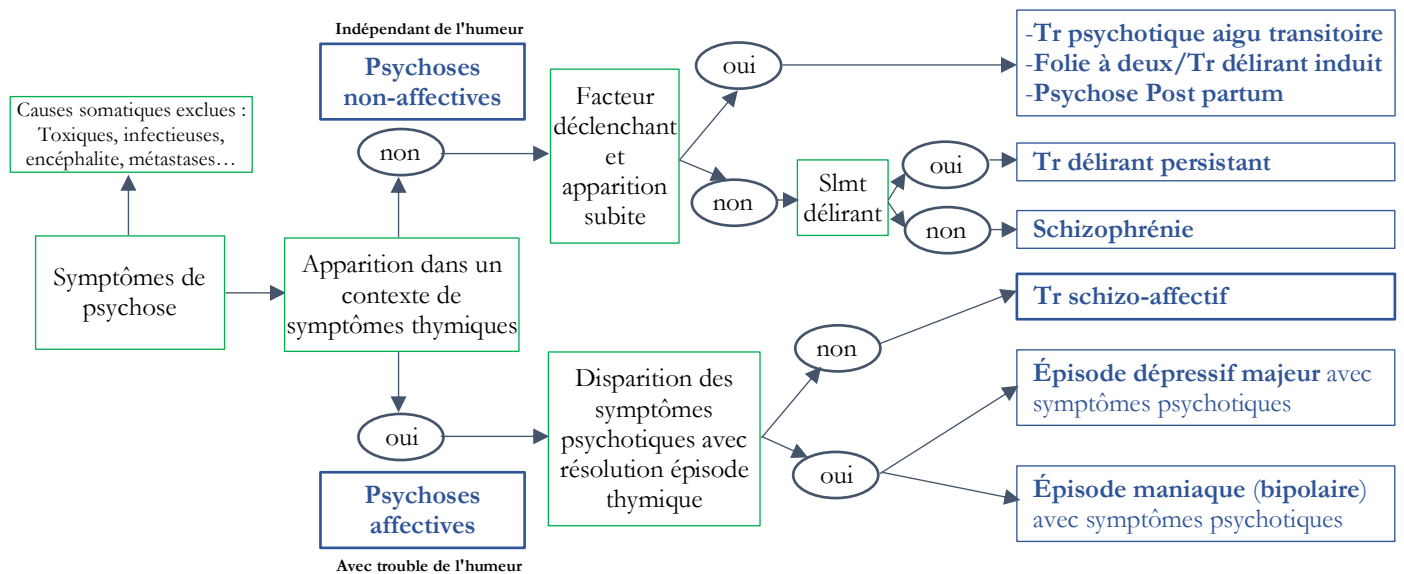
3. *Troubles du moi*

- Troubles de l'éprouvé de l'autre ou de l'environnement, du vécu d'unité du moi ou de l'apparence du moi
 - **Dépersonnalisation** (sentiment d'être irréel, transformé)
 - **Déréalisation** (personnes et objets semblent irréels)
 - **Devinement de la pensée** (les pensées n'appartiennent plus au patient, d'autres y participent et savent ce qu'il pense)
 - **Vol de la pensée** (pensées sont enlevées ou prélevées)
 - **Pensées imposées** (pensées sont vécues comme influencées, fabriquées, dirigées ou gouvernées)

4. *Troubles formels du cours de la pensée*

- Se manifestent dans le langage (peuvent aussi s'observer chez les **bipolaires**) et traduisent un flux ou une organisation déficiente de la pensée
 - **Pensée ralentie**
 - **Pensée circonscrite** (ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire)
 - **Fuite des idées** (afflux d'idées que ne sont pas dirigées par un projet ; but de la pensée est en changement permanent)
 - **Réponses à côté** (réponses incongrues même à des questions simples)
 - **Néologismes** (création de nouveaux mots)
 - **Pensée incohérente**

d. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE



- **PSYCHOSES AFFECTIVES** : les symptômes psychotiques ne sont présents que dans le contexte d'un trouble de l'humeur
 - Tr bipolaire à caractéristiques psychotiques
 - État dépressif à caractéristiques psychotiques
- **PSYCHOSES NON-AFFECTIVES** : les symptômes psychotiques sont présents indépendamment de variations de l'humeur
 - **Tr psychotique aigu et transitoire**
 - Tr psychotique d'apparition aiguë (< 2 semaines)
 - Plus l'apparition est aiguë, meilleur est le pronostic (< 48h)
 - Présence d'un facteur de stress aigu :
 - Deuil
 - Traumatisme de combat, de torture, terrorisme
 - Perte inattendue d'une relation affective
 - Perte d'emploi
 - Mariage ...
 - 2 formes selon les types de symptômes psychotiques présents :
 - **Polymorphe**
 - *Hallucination, idées délirantes*, perturbation des perceptions très variables d'une heure à l'autre
 - Présence fréquente d'un bouleversement émotionnel, passage d'extase à irritabilité et anxiété
 - Apparition le plus souvent brutale (48h) et disparition souvent rapide
 - S'il persiste > 3 mois : revoir le diagnostic pour un **tr délirant persistant**
 - **D'allure schizophrénique**
 - Symptômes psychotiques relativement stables, moins de variabilité émotionnelle durant la journée
 - Présence de *troubles du moi, écho de la pensée, hallucinations auditives* de voix commentant le comportement, parlant du sujet à la 3^{ème} personne
 - S'il persiste > 1 mois : modifier le diagnostic pour une **schizophrénie**
 - **Tr délirant induit ou Folie à deux**
 - Trouble délirant rare
 - Partagé par deux ou un groupe de personnes
 - Une seule des personnes présente un trouble psychotique authentique
 - Les idées délirantes induites chez la ou les autres personnes disparaissent en cas de séparation
 - Thèmes habituels : persécution ou grandeur
 - Le plus souvent, lié à l'établissement d'une relation d'une intensité inhabituelle (raisons culturelles, linguistiques, sociales)
 - Diagnostic :
 - Deux ou plusieurs personnes partagent la même idée délirante
 - Il existe une relation très étroite entre ces personnes
 - On met en évidence des arguments chronologiques montrant l'induction du délire chez l'un par l'autre
 - Les hallucinations sont extrêmement rares
 - **Psychose du post partum**
 - Apparition rapide, chez des femmes habituellement sans antécédent psychiatrique, dans les 6 à 48h après l'accouchement de :
 - Euphorie, hyperactivité, fuite des idées, hyper-sociabilité, troubles du sommeil
 - Délire (mégalo-maniaque ou paranoïde) à son propre sujet ou à celui de l'enfant
 - Possibilité d'éléments dépressifs également
 - Évolution sans traitement incertaine et pouvant durer plusieurs mois
 - Risque majeur pour l'enfant

- **Traitement :**
 - Médication : antipsychotiques ou stabilisateurs de l'humeur
 - Hospitalisation de la mère
 - Si pas d'encadrement possible de l'enfant : placement en foyer et visites
 - Hospitalisation dans une unité mère-bébé
- **Tr délirant persistant** (France: **Délire paranoïaque chronique**)
 - Trouble marqué par la présence isolée d'une symptomatologie délirante, sans autres symptômes psychotiques
 - Délire systématisé (habituellement paranoïde ou de grandeur)
 - Faible réponse au traitement neuroleptique
- **Schizophrénie(s)** (Bleuler - 1908)
 - Le terme schizophrénie s'applique à un groupe hétérogène de troubles
 - Ces troubles ont en commun :
 - Un certain nombre de symptômes présents pendant > 1 mois
 - Symptômes psychotiques (positifs) dans les phases aiguës
 - Symptômes négatifs
 - Troubles cognitifs
 - Symptômes fondamentaux selon Bleuler (1908) :
 - Symptômes primaires (fondamentaux), issus du processus pathologique (présents chez tous les patients et persistent aux cours du temps) :
 - *Associations relâchées*
 - *Troubles des Affects (affect aplati)*
 - *Ambivalence*
 - *Autisme*
 - (+ *Avolition et troubles de l'Attention*)
 - Symptômes secondaires (accessoires), issus de la réaction du psychisme du malade :
 - *Hallucinations*
 - *Idées délirantes*
 - *Troubles cognitifs*
 - *Symptômes catatoniques*
 - Évolution du concept selon Andreasen (1982) :
 - Symptômes positifs
 - *Hallucinations - Délire - Troubles de la pensée formelle - Comportement désorganisé*
 - Pas pathognomonique de la schizophrénie
 - Plus typiques de la phase aiguë de la maladie
 - Répondent mieux aux antipsychotiques
 - Liés à une hyperactivité dopaminergique de la voie meso-limbique ?
 - Symptômes négatifs
 - *Affect aplati - Alogie - Anhédonie et retrait social - Apathie*
 - Associés à un état déficitaire, à un mauvais fonctionnement prémorbide, et à un mauvais pronostic
 - Relativement stables et peu ou pas réversibles, difficiles à différencier des symptômes dépressifs
 - Résistants aux antipsychotiques
 - Liés à une hypoactivité dopaminergique de la voie meso-corticale (atteinte du lobe frontal) ?
 - Troubles cognitifs
 - Présents chez 60-80% des patients
 - Sont présents aussi chez les proches de 1^{er} degré
 - Sont déjà présents dans la phase prodromique
 - Les compétences cognitives sont importantes pour la réhabilitation et déterminent le pronostic
 - Domaines de déficit les plus fréquents :
 - Attention
 - Mémoire
 - Fonctions exécutives
 - Cognition sociale
 - Formes cliniques (dans la nouvelle classification : plutôt l'historique que le contenu) :
 - **Schizophrénie paranoïde**
 - La plus fréquente
 - Symptômes positifs : *délire paranoïde* et *hallucinations*
 - Symptômes négatifs peuvent être présents
 - **Schizophrénie hébéphrénique**
 - Prédominance de *désorganisation de la pensée*
 - Perturbation des affects et du comportement
 - Apparition précoce de symptômes négatifs

- **Schizophrénie catatonique**
 - Stupeur ou excitation
 - Posture catatonique, négativisme, rigidité, flexibilité cireuse
- **Schizophrénie indifférenciée**
- **Schizophrénie résiduelle**
 - Symptômes positifs atténués
 - Symptômes négatifs

Diagnostic CIM 10 :

Épidémiologie :

- Touche environ 1% de la population mondiale
- Incidence : ~2 nouveaux cas/10'000 hab./ans
- Début :
 - 18-25 ans pour les hommes
 - 24-35 ans pour les femmes (2nd pic d'incidence chez les femmes ménopausées)

Espérance de vie :

- 20% inférieur à la population générale
- Causes principales de l'excès de mortalité :
 - Suicide
 - Maladies respiratoires et infectieuses
 - Abus de substances
 - Maladies cardiovasculaires

Évolution à long terme :

- 25% de guérison
- 25% de forme récidivantes
- 50% de forme chronique et défavorable

Étiologie :

- Pas liée à un seul facteur
- Interaction de divers facteurs intrinsèques et extrinsèques
- Facteurs de risque pré-morbides confèrent une vulnérabilité
- Facteurs influençant la vulnérabilité :
 - Biologiques :
 - Génétique
 - Lésions cérébrales (sur maladie ou trauma)
 - Complications obstétricales pré ou périnatales
 - Déficit en glutathion
 - Psychologiques et environnementaux :
 - Trauma psychologique, sexuel
 - Migration
 - THC ou autres substances
 - Urbanité

Comorbidités :

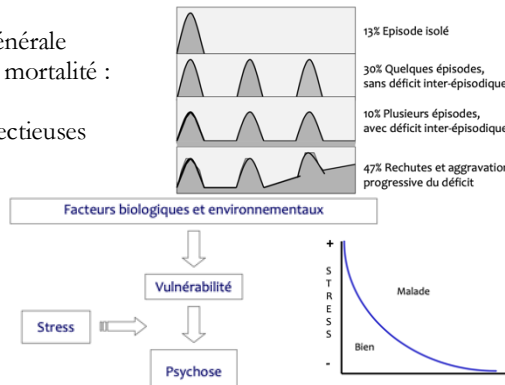
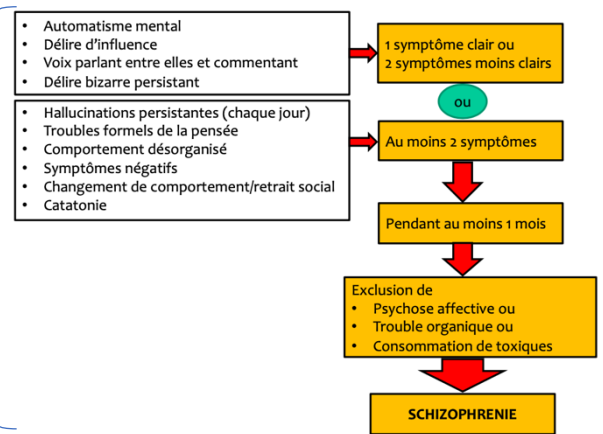
- Les patients atteints de schizophrénie présentent fréquemment des pathologies associées :
 - Dépression
 - Abus de substances
 - Troubles obsessionnels compulsifs
 - Anxiété

Traitements :

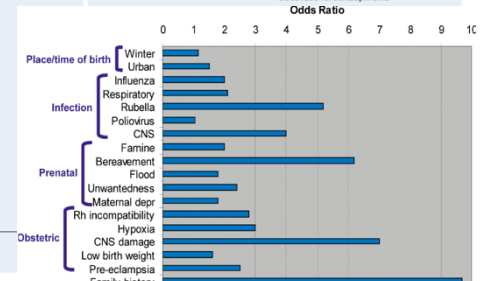
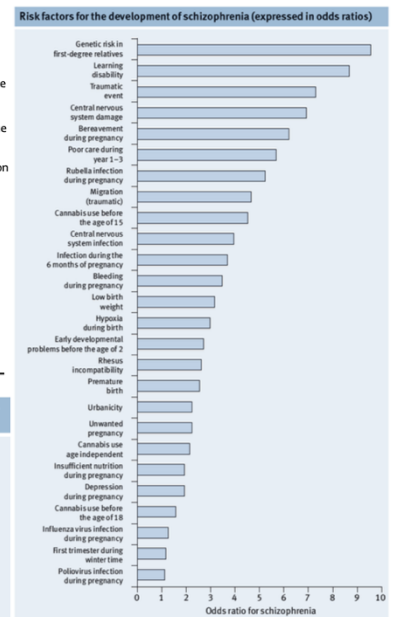
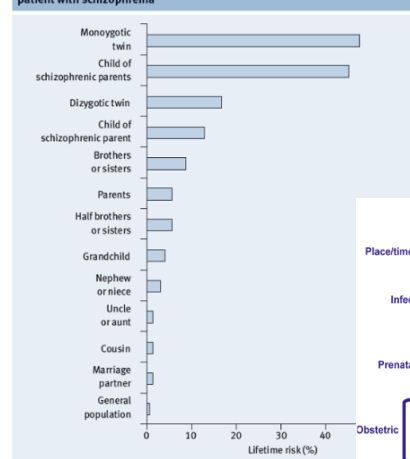
- PEC globale (pluridisciplinaire) et combinée :
 - Traitement biologique (**Neuroleptiques**)
 - **Psychothérapie**
 - Traitements psychologiques
 - Traitement psycho-social
 - Réhabilitation - soutien à l'emploi
 - Majorité en milieu ambulatoire :
 - Consultations en polyclinique
 - Équipes mobiles
 - +/- brèves phases d'hospitalisation

● **TROUBLE SCHIZO-AFFECTIF** : trouble épisodique marqué par :

- La présence conjointe de :
 - Symptômes affectifs :
 - *Manie*



Lifetime risk for schizophrenia according to genetic and family relationship to patient with schizophrenia



- *Dépression*
- Symptômes psychotiques :
 - *Délire*
 - *Hallucinations*
 - *Troubles de la pensée formelle*
- La persistance des symptômes psychotiques au-delà de 2 semaines après la résolution de l'épisode affectif

2) Troubles de l'humeur (Despland)

Critères diagnostiques très importants

- Humeur déprimée
- Perte d'espoir
- Sentiment d'insuffisance
- Sentiment de culpabilité
- Sentiment de ruine
- Dysphorie (mauvaise humeur)
- Irritabilité
- Agitation intérieure
- Labilité affective
- Euphorie

Enjeux cliniques

1. Accueillir : un cadre adéquat
 2. Investiguer : poser un diagnostic et proposer un plan de traitement
 3. Nommer : mettre en mot les symptômes du patient (émotions, cognitions, symptômes physiques)
 4. Rencontrer : être capable de se mettre à la place du patient - empathie et alliance thérapeutique
- "L'humeur [= thymie] est cette disposition affective fondamentale [...] qui donne à chacun de nos états d'âmes, une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. " (J. Delay)
 - Une émotion qui se prolonge
 - Variations de l'humeur = phénomène normal
 - Humeur et variations pathologiques quand :
 - Intenses
 - Prolongées
 - Entraînant une souffrance significative pour le sujet et son entourage
 - Et/ou un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet

a. Épisodes thymiques

"L'épisode thymique est le mot, le diagnostic la phrase"

- Les 4 épisodes thymiques sont les 4 tableaux cliniques que notre patient pourrait présenter → diagnostic de tr de l'humeur

1. Épisode Dépressif Caractérisé (EDC)

- ▶ Examen clinique (L'abécédaire de Michel Ouellebeck)
 1. Présentation : *sans particularité, terne, cernes, lenteur d'expression, peu expressif, regard évitant*
 2. Psychomotricité : **ralenti, peu expressif**
 3. Langage : **ralenti, monocorde**
 4. Cours de la pensée : **rétréci, ruminations, pensée inhibée**
 5. Délire : pas de délire
 6. Perceptions : pas d'hallucination
 7. Expression des émotions et humeur : *pauvre, monotone, humeur dépressive*
 8. Attitude et contact : **soliloque** (se parle à lui-même, pense tout haut), **égocentrique**
- ▶ Symptômes psychiques
 1. **Humeur dépressive** :
 - *Douleur morale : vide, pesanteur, lenteur*
 - **Émoussement affectif**
 - **Anxiété**
 - **Irritabilité**
 - **Idées suicidaires**
 2. **Pessimisme**
 3. **Auto dévalorisation, culpabilité, indignité**
 4. **Anhédonie** (incapacité à prendre du plaisir dans des activités habituellement appréciées)
- ▶ Symptômes psychomoteurs
 5. **Fatigue**
 6. **Ralentissement** ou **agitation**
 - **Perte de l'élan vital**
 - **Bradypsychie** (ralentissement du cours de la pensée)
 - **Bradyphémie** (lenteur du rythme verbal)
 - **Bradykinésie** (ralentissement des mouvements et perte de la finesse du mouvement comme l'écriture)
 - **Aboulie (avolition)** (perte de la volonté entraînant une inhibition de l'activité physique et intellectuelle)
 - **Faciès figé**
- ▶ Autres symptômes

- 7. **Troubles de la concentration et de la mémoire**
- 8. **Insomnie** ou **hypersomnie**
- 9. **Anorexie** et **perte de poids** ou **prise de poids**
 - **Diminution de la libido**
 - **Alcoolisations**
 - **Douleurs fonctionnelles**
 - **Constipation**
 - **Troubles cognitifs** (personne âgée)
- Épisode dépressif caractérisé DSM-5
 - Un symptôme pendant au moins deux semaines :
 1. *Humeur dépressive*
 2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir (*anhédonie*)
 - Quatre symptômes pendant au moins deux semaines :
 3. *Fatigue* ou *perte d'énergie*
 4. *Diminution de l'aptitude à penser* ou *à se concentrer*
 5. *Insomnie* ou *hypersomnie*
 6. *Perte ou gain de poids significatif* (5%)
 7. *Agitation* ou *ralentissement psychomoteur*
 8. *Sentiment de dévalorisation* ou *de culpabilité excessive*
 9. *Pensées de mort* ou *idées suicidaires récurrentes*
- Épisode dépressif CIM-10
 - Deux symptômes pendant au moins deux semaines :
 1. *Humeur dépressive*
 2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir (*anhédonie*)
 3. *Fatigue* ou *perte d'énergie*
 - Deux symptômes pendant au moins deux semaines :
 4. *Diminution de l'aptitude à penser* ou *à se concentrer*
 5. *Trouble du sommeil*
 6. *Perte de poids significative*
 7. *Agitation* ou *ralentissement psychomoteur*
 8. *Sentiment de culpabilité* et *de dévalorisation*
 9. *Pessimisme*
 10. *Pensées de mort* ou *idées suicidaires récurrentes*
- Anamnèse
 - Spontanée (le patient nous parlera généralement spontanément) :
 - *Troubles neurovégétatifs*
 - *Fatigue* ou *perte d'énergie*
 - *Insomnie* ou *hypersomnie*
 - *Diminution de l'aptitude à penser* ou *à se concentrer* ou *indécision*
 - Dirigée (à investiguer) :
 - *Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir*
 - *Humeur dépressive*
 - *Sentiment de dévalorisation* ou *de culpabilité excessive*
 - *Perte ou gain de poids significatif*
 - *Idées suicidaires récurrentes*
- La dépression au masculin

Critères vus plus facilement chez les hommes :

- Agitation et irritabilité vs tristesse
 - *Impulsif*
 - *Fâché, grincheux*
 - *Hostile, revendicatif*
- Comportements compulsifs vs apathie
 - *Excès de travail*
 - *Alcool, drogues* (CAVE suicidalité)
 - *Addictions* au sexe, sport, jeu
- Crise de colère vs abattement
- **Burn out** et **fatigue pandémique**

La distinction entre état dépressif et burn out est parfois difficile.

Sont des symptômes dépressifs sans l'humeur dépressive !

- Niveau psychique
 - *Épuisement*
 - *Démotivation, lassitude*
 - *Attitude négative*
 - *Détachement*
- Niveau somatique
 - *Trouble du sommeil*

- *Épuisement*
- Niveau comportemental (relationnel)
 - *Difficultés relationnelles*
 - *Désengagement*

Burn out et fatigue pandémique peuvent se compliquer d'une **dépression**

2. Épisode Maniaque

L'état maniaque est subjectivement un état de bonheur total mais objectivement amène à une perte de contact avec la réalité et une mise en danger de soi et de la famille. Anosognosie voir ne se souviennent pas des épisodes maniaques.

Un **épisode maniaque** complet qui apparaît au cours d'un traitement antidépresseur doit conduire à un diagnostic de **trouble bipolaire I**

► Examen clinique (JC Van Damme)

1. Présentation : *sportive, négligée* (?)
2. Psychomotricité : **augmentation du dynamisme, agitation, excitation**
4. Langage : *bruyant, logorrhétique* (parle vite et beaucoup)
5. Cours de la pensée : **fuite des idées** (=parle de manière logorrhétique et avec incohérence) est spécifique de l'épisode maniaque, **incohérence**, *associations par assonances*
6. Délire : *surestimation de soi, égocentrisme, grandeur*
7. Perceptions : **pas d'hallucination**
8. Expression des émotions et humeur : *expansive, euphorique, labile*
9. Attitude et contact : **séductrice** (CAVE : patient trop familier), *ludique*

► Symptômes psychiques

- Humeur *exaltée, euphorique, expansive*
- **Labilité** et **versatilité émotionnelle** (joie, irritabilité, agressivité)
- Contact **hypersyntone** (plus grande communicabilité)
- **Idées de grandeur** :
 - Caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur :
 - Mécanismes interprétatifs avec des thèmes mégalomaniques
 - Caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur :
 - Persécution, influence

► Symptômes psychomoteurs

- Activation psychique
 - **Tachypsychie** (accélération anormale du rythme de la pensée créant un état de surexcitation)
 - **Fuite des idées**
 - **Logorrhée**
 - **Ludisme** et **jeux de mots**
 - **Graphorrhée** (besoin pathologique d'écrire)
 - **Distractibilité**
- Activation motrice
 - **Tachykinésie** (hyperactivité, agitation désordonnée)
 - **Hypermimie** (Augmentation anormale du nombre et de l'intensité des expressions faciales)
 - **Désinhibition instinctivo-comportementale**

► Autres symptômes

- **Désinhibition sociale** (amène la mise en danger) et **hypersexualité**
- Réduction du besoin de sommeil, **insomnie**
- **Anorexie** et **perte de poids** (ou prise de poids)

• Épisode maniaque DSM-5

- Période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est anormalement élevée, expansive ou irritable
- Augmentation anormale et persistante de l'activité orientée vers un but ou de l'énergie
- Persistant la plupart du temps, presque tous les jours, pendant au moins une semaine (ou toute autre durée si une hospitalisation est nécessaire)
- Au moins 3 des symptômes suivants (4 si seulement irritabilité) :
 1. *Augmentation de l'estime de soi* ou *idées de grandeur*
 2. *Plus grande communicabilité*, désir de parler constamment (*logorrhée*)
 3. *Fuite des idées* (objective ou subjective)
 4. *Distractibilité*
 5. *Réduction du besoin de sommeil*
 6. Engagement excessif dans des activités agréables mais avec des conséquences dommageables (financières, sexuelles)
 7. Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, scolaire, sexuel) ou agitation psychomotrice

• Anamnèse

- Spontanée :
 - Peu d'information donnée par le patient (anosognosique, déni de la maladie et caractéristiques de l'humeur)
- Dirigée :
 - Centrée sur les comportements
 - Rythme veille-sommeil
 - Dépense
 - Comportement social

- Projets professionnels
- Hétéro anamnèse :
 - Indirecte (vous a-t-on fait des remarques sur...)
 - Directe (contact avec les proches)

3. Épisode Hypomaniaque

Un épisode hypomaniaque complet qui apparaît au cours d'un traitement antidépresseur doit conduire à un diagnostic de ???

- Symptômes identiques à l'épisode maniaque
- Dure au moins 4 jours (et non une semaine)
- Intensité moindre :
 - Pas d'altération marquée du fonctionnement social et professionnel
 - Peut prendre la forme d'une amélioration de l'efficacité, des réalisations ou de la créativité
 - Jamais de symptômes psychotiques (idées délirantes)
 - Hospitalisation pas nécessaire
- Épisode hypomaniaque DSM-5
 - Période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est anormalement élevée, expansive ou irritable
 - Augmentation anormale et persistante de l'activité orientée vers un but ou de l'énergie
 - Persistant la plupart du temps, presque tous les jours, pendant au moins 4 jours
 - La sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social, ou pour nécessiter une hospitalisation.
 - S'il existe des caractéristiques psychotiques, l'épisode est, par définition, maniaque
 - Au moins 3 des symptômes suivants (4 si seulement irritabilité) :
 1. *Augmentation de l'estime de soi* ou *idées de grandeur*
 2. *Plus grande communicabilité*, désir de parler constamment (*logorrhée*)
 3. *Fuite des idées* (objective ou subjective)
 4. *Distractibilité*
 5. *Réduction du besoin de sommeil*
 6. Engagement excessif dans des activités agréables mais avec des conséquences dommageables (financières, sexuelles)
 7. Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, scolaire, sexuel) ou agitation psychomotrice

► DD manie et hypomanie

Sauf les symptômes psychotiques, les différences sont seulement quantitatives

- Hypomanie
 - Légère, moins grave
 - Altération du fonctionnement faible à modérée
 - Erreurs de jugement moindres/limitées
 - Répond fréquemment au traitement ambulatoire
 - Régulation du sommeil et/ou emploi de benzodiazépines peut parfois aider à maîtriser les épisodes hypomaniaques
- Manie
 - Grave
 - Altération marquée du fonctionnement
 - Erreurs de jugement importantes
 - Symptômes psychotiques
 - Nécessite souvent une hospitalisation
 - Requiert un traitement aigu par un thymorégulateur et/ou un antipsychotique

4. Épisode Mixte

80% des patients présentent les 2 types de symptômes de façon rapprochée (dans la même journée)

- Le patient se plaint de :
 - Anxiété
 - Tension intérieure
 - Tension musculaire
 - Sentiments d'irritabilité et de rage non provoquée
 - Pensée encombrée ou accélérée
 - Insomnie d'endormissement ou du milieu de la nuit
 - Idées et impulsions suicidaires
- Le conjoint dit que le patient :
 - Se plaint continuellement
 - Manifeste parfois de l'irritabilité
 - Est parfois sexuellement hyperactif
- Le patient présente :
 - Une humeur déprimée
 - Une agitation psychique
 - Une expression faciale pleine de vie
 - Des descriptions poignantes de souffrance
 - L'absence de ralentissement
 - Une volubilité

- Une labilité émotionnelle
- Des gestes suicidaires impulsifs
- Une tension diastolique élevée

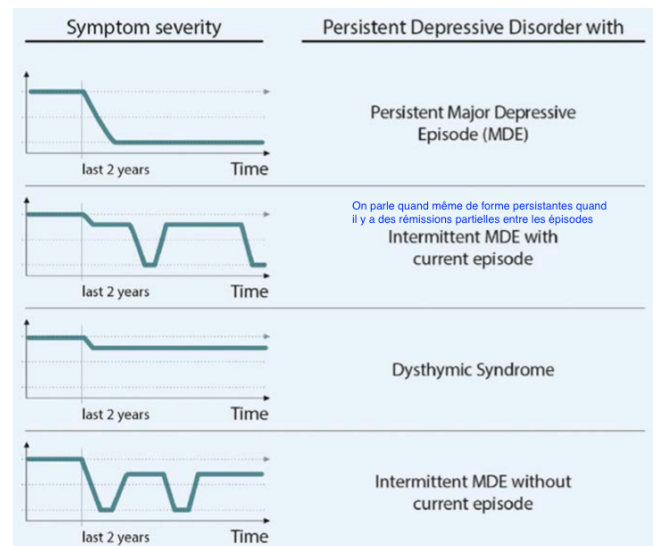
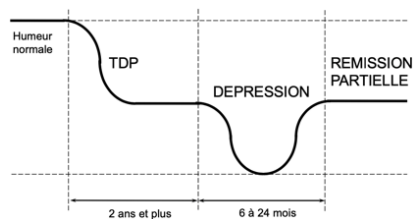
b. Dépressions

- Fréquentes (OBSAN 56/2013) :
 - 7% de la population suisse chaque année
 - 30% des consultations en médecine générale
- Récidivantes (au moins 50%)
- Chronicisation possible (15-30%)
- Handicapantes :
 - Sur le plan familial, social, professionnel, financier
 - 10 à 30% ont des symptômes résiduels invalidants (AI)
- Létales :
 - Risque plus élevé de suicide (10-15%) et d'accidents
- Forte comorbidité somatique :
 - Maladies cardiaques, troubles respiratoires, accidents vasculaires cérébraux, syndrome métabolique plus fréquents
- **Troubles dépressifs du DSM 5**
 - Trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur
 - **Trouble dépressif caractérisé** :
 - Isolée
 - **Récurrent** (la récurrence est fréquente et plus le patient est récurrent, plus il a de chance d'en refaire)
 - Durée d'un épisode variable (quelques semaines à plusieurs mois sans traitement)
 - 60-70% de rémission totale si traitement adéquat
 - Le risque de récurrence est important :
 - 1er épisode : 50%
 - 2ème épisode : 70%
 - 3ème épisode : 80%
 - 4ème épisode : 85%
 - Les formes récurrentes présentent une fréquence variable
 - Rémissions totales ou partielles entre les épisodes
 - Formes chroniques (15-30%)
 - Évolution longitudinale (rémission, dysthymie)
 - Caractère saisonnier
 - Est une forme particulière (purement biologique) de la forme récurrente et a un **traitement thérapeutique simple**
 - Symptômes :
 - Baisse de l'élan vital, ralentissement, asthénie, hibernation
 - Appétit exagéré, fringale sucrée, prise de poids
 - Hypersomnie
 - Facteurs de risque :
 - Sujets jeunes
 - 4 femmes pour 1 hommes
 - Réponse favorable à la **luminothérapie** (si suspicion, doit faire un test thérapeutique de luminothérapie) :
 - 10'000 lux 30 minutes/jour (soleil d'été : 20'000 lux/30 minutes)
 - 2500 lux 1-2 heures jour
 - Durée minimum : 1-2 semaines
 - Remboursé par les caisses (800 Frs ou 2 Frs/jour)
 - ▶ Les symptômes du **trouble dépressif caractérisé** sont ceux de l'**épisode thymique**
 - Un symptôme essentiel pendant au moins deux semaines :
 1. Humeur dépressive
 2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir (anhédonie)
 - Quatre symptômes pendant au moins deux semaines :
 3. Fatigue ou perte d'énergie
 4. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive
 5. Pensées de mort ou idées suicidaires récurrentes
 6. Agitation ou ralentissement psychomoteur
 7. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, indécision
 8. Insomnie ou hypersomnie
 9. Perte ou gain de poids significatif (5%)
 - Sévérité :
 - Léger-5 (≥ 1 essentiel et 4 autres)
 - Moyen-6 (≥ 1 essentiel et 5 autres)
 - Grave-7 (≥ 1 essentiel et 6 autres)
 - Spécifications des **épisodes dépressifs** :
 - Avec **détresse anxieuse**
 - Sensation d'énervement ou de tension intérieure

- Sensation d'agitation inhabituelle
- Difficulté à se concentrer en raison de l'inquiétude
- Peur que quelque chose de terrible n'arrive
- Impression de perte de contrôle de soi-même
- Spécifier la sévérité actuelle :
 - Léger : Deux symptômes.
 - Moyen : Trois symptômes.
 - Moyennement grave : Quatre ou cinq symptômes.
 - Grave : Quatre ou cinq symptômes avec agitation motrice
- Avec caractéristiques **mélancolique** (dépression très sévère)
 - Perte de plaisir ou de réactivité
 - Au moins 3 symptômes suivants :
 - Qualité de l'humeur
 - Pire le matin
 - Réveils précoces
 - Ralentissement ou agitation
 - Perte de poids ou d'appétit
 - Culpabilité
- Avec caractéristiques **atypique** (importante du aux hypothèses somatiques)
 - Réactivité de l'humeur
 - Au moins 2 symptômes suivants :
 - Augmentation du poids ou de l'appétit
 - Hypersomnie
 - Lourdeur dans les membres
 - Sensibilité au rejet
- Avec caractéristiques **mixtes**
 - Dépression caractérisée + 3 symptômes :
 - Humeur élevée, expansive
 - Augmentation de l'estime de soi, idées de grandeur
 - Plus grande communicabilité
 - Fuite des idées
 - Augmentation de l'énergie ou de l'activité
 - Engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables
 - Réduction du besoin de sommeil
- Avec caractéristiques **psychotiques**
 - Congruentes à l'humeur
 - Non congruentes à l'humeur
 - Symptômes psychotiques :
 - Idées délirantes, éventuellement hallucinations
 - Thématiques :
 - Culpabilité délirante
 - Punition méritée, damnation
 - Ruine
 - Nihilisme de soi et du monde
 - Pourrissement du corps
 - Voix hostiles, accusatrices
 - Syndrome de Cotard :
 - Négation
 - Damnation
 - Immortalité
- Avec **catatonie** (rare mais souvent trouvé dans la **dépression mélancolique** donc sévère)
 - Immobilité motrice avec catalepsie
 - Négativisme, mutisme
 - Stéréotypies gestuelles
 - Écholalies (répétition automatique des paroles), échopraxies (échokinésie) (tendance involontaire à imiter les mouvements d'un autre individu)
- Avec début dans le **péri-partum**
 - N'est pas la même chose que le baby blues
 - 10% des femmes connaissent un EDM dans les mois qui suivent une naissance
 - 50% ont encore des symptômes dépressifs après 6 mois
 - Rechute chez 30% des femmes
 - Facteurs de risques spécifiques :
 - Anamnèse de dépression(s) antérieure(s)
 - Relation conjugale conflictuelle
 - Manque de soutien social
 - Environnement difficile (facteurs de stress)

- **Trouble dépressif persistant (dysthymie)**

- A. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, plus d'un jour sur deux pendant au moins deux ans, signalée par le sujet ou observée par les autres
- B. Quand le sujet est déprimé il présente au moins deux des symptômes suivants :
 1. perte d'appétit ou hyperphagie
 2. insomnie ou hypersomnie
 3. baisse d'énergie ou fatigue
 4. difficultés de concentration ou difficultés à prendre des décisions
 5. faible estime de soi
 6. sentiments de perte d'espoir
- C. Au cours de la période de deux ans (un an pour les adolescents) de perturbation thymique, le sujet n'a jamais eu de période de plus de deux mois consécutifs sans présenter les symptômes des critères A et B
- Psychopathologie
 - Comorbidité pour les troubles de la personnalité, troubles anxieux et abus de substances
 - Problèmes interpersonnels marqués
 - Problèmes familiaux
 - Traumatismes infantiles multiples
- Évolution
 - 40% des patients développent un trouble uni- ou bipolaire
 - Mortalité par suicide de 3%-12%
 - Hospitalisations fréquentes
 - Évolution sociale défavorable dans 60% des cas
 - Chronicité pour 80% des patients (dépressions majeures 15-30%)
- Dépression double



- **Trouble dysphorique prémenstruel**

- A. Au cours de la plupart des cycles menstruels, au moins 5 des symptômes suivants ont été présents lors de la dernière semaine avant le début des règles ; ils ont commencé à s'améliorer au cours des premiers jours après le début des règles et ils deviennent minimales voire absents dans la première semaine après les règles
- B. Un (ou plus) des symptômes suivants doit être présent :
 - Labilité émotionnelle marquée
 - Colère ou irritabilité marquée ou augmentation des conflits interpersonnels
 - Humeur dépressive marquée, sentiments de désespoir ou autodépréciation
 - Anxiété marquée, tension, impression d'être noué ou tendu
- C. Un ou plus des symptômes suivants doit de plus être présent pour atteindre un total de 5 symptômes en tout (avec les critères B ci-dessus) :
 - Diminution de l'intérêt pour les activités habituelles
 - Difficultés subjectives à se concentrer
 - Léthargie, fatigabilité excessive ou perte d'énergie marquée
 - Symptômes physiques tels que tension ou gonflement des seins, douleurs articulaires ou musculaires, impression d'enfler ou prise de poids
- D. Les symptômes s'accompagnent de détresse cliniquement significative ou interfèrent avec le travail, l'activité scolaire, les activités sociales habituelles ou les relations avec les autres (p ex évitement des relations sociales, diminution de la productivité ou de l'efficacité au travail, à l'école ou à la maison)
- E. La perturbation ne correspond pas seulement à l'exacerbation des symptômes d'un autre trouble comme un trouble dépressif caractérisé, un trouble panique, un trouble dépressif persistant (dysthymie) ou un trouble de la personnalité (bien qu'elle puisse se surajouter...)
- F. Le critère A doit être confirmé par des évaluations prospectives quotidiennes pendant au moins deux cycles symptomatiques (NB Avant cette confirmation le diagnostic peut être porté à titre provisoire)
- G. Les symptômes ne sont pas attribuables aux effets physiologiques d'une substance (p ex une substance donnant lieu à abus, un médicament, un autre traitement) ou à une autre affection médicale (p ex une hyperparathyroïdie)

- **Trouble dépressif induit par un médicament**
- **Trouble dépressif dû à une autre affection médicale**
- **Autre trouble dépressif spécifié**
- **Trouble dépressif non spécifié (NS)**

► **DD** (très large) des **dépressions**

- Causes somatiques
 - Troubles **endocriniens**
 - Maladies **neurologiques**
 - **Démence** chez le sujet âgé
- **EDM** induit par une substance
 - Certains médicaments (interféron alpha, corticoïdes, β -bloquants...)
 - Intoxication ou sevrage à certaines drogues
- Si forme **délirante** ou **stuporeuse** :
 - **Confusion** (= cause somatique)
 - **Troubles psychotiques** (schizophrénie)
- Deuil
- Épidémiologie des **troubles dépressifs**
 - Prévalence :
 - ~7% sur une année et 10-15% sur la vie
 - 2 fois plus fréquent chez la femme à partir de l'adolescence (20% chez les femmes et 10% chez les hommes)
 - Maximale entre 25 et 45 ans
 - Début possible à tout âge
 - Age moyen du 1er épisode dépressif = 30 à 35 ans
 - Pas vraiment de période de vie plus sujettes à la dépression
 - Très présente en Suisse latine

• Facteurs de risques

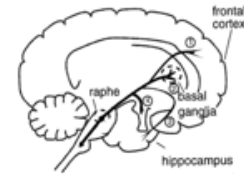
- **Hérédité** (le plus grand FR)
- Sexe féminin
- Postpartum
- Problèmes somatiques
 - Maladies cardiaques, CV
 - Alzheimer, Parkinson
 - Épilepsie récurrente/contrôlée
 - Diabète
 - Cancer
 - HIV/SIDA
 - Douleurs chroniques
 - Obésité
- Personnalité borderline et obsessionnelle
- Niveau de formation bas
- Contexte social :
 - Situation conjugale (solitude [avec enfant], séparation, divorce)
 - Situation professionnelle (chômage)
 - Immigration
- Événements de vie (infantiles, actuels)
- Personnes/situations plus à risque
 - Personnes âgées
 - Immigrés
 - Faible niveau de formation
 - Séparation et divorce
 - Familles monoparentales
 - Lieu d'habitations

• Évolution et Complications

- Conséquences familiales, sociales, professionnelles
 - Problèmes relationnels
 - Incapacité de travail et rente AI
- Conséquences médicales
 - Problèmes somatiques
 - ES des médicaments
 - Qualité de la PEC
- Suicide chez 10-15% des patients
 - Chez 90% des suicidés (Autopsies Psychiatriques) :
 - Dépression : 50%
 - Tr de la personnalité : 35%
 - Alcoolisme : 30%
 - Schizophrénie : 6%
 - Évaluation du risque suicidaire (à faire et à noter dans le dossier)
 1. Pensez-vous parfois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ?

	Jumeaux monozygotes (%)	Jumeaux dizygotes (%)	Ratio Odds ratio (MZ/DZ)
Si 1 jumeau est atteint de tr. bipolaires, l'autre a 73% d'en avoir aussi	73	14	5.2
Troubles bipolaires	42	14	3.1
Troubles unipolaires	53	16	3.4
Schizophrénies			

2. Avez-vous parfois pensé que la mort serait une solution à vos souffrances ?
3. Avez-vous déjà pensé au suicide ?
4. Quand ? Dans quelles circonstances ? À quelle fréquence ?
5. Combien de temps cela a-t-il duré ?
6. Avez-vous un plan précis ?
7. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?



1. Dépression
2. TOC
3. Trouble panique
4. Boulimie

- **Étiopathologie** (que des hypothèses)

- Amines biogènes

- Localisation des récepteurs 5HT_{1A}
- Anomalies fonctionnelles ou structurales associées à la dépression (on ne sait pas s'ils sont la cause ou la conséquence de la dépression)

- Axe endocrinien

- Rythme du sommeil

Les patients sensibles aux antidépresseurs ont une hyperactivité de l'insula

Les antidépresseurs inhiberaient donc l'activité de l'insula

Les patients sensibles à la psychothérapie ont une hypoactivité de l'insula

- **Le traitement des dépressions**

- Aspects généraux du traitement

- Coopération entre le patient et le médecin (partenariat)
- Informations : diagnostic, pronostic, options thérapeutiques, durée et effets secondaires des traitements
- Proposer un cadre à la relation
- Entretiens de couple et de famille

- Informer les patients

- La dépression est une maladie qui se soigne
- Plusieurs options thérapeutiques
- De manière générale, les traitements sont efficaces
- Objectif : rémission complète des symptômes
- Informations : symptômes, évolution, signes de rechute

- Modalités de traitement

- Médication
- Psychothérapie
- Combinaison médication-psychothérapie
- Luminothérapie
- Hospitalisation
- ECT

- **Psychothérapie vs pharmacothérapie**

- Pas de pharmacothérapie sans une dimension psychothérapeutique
- Choix des patients à respecter
- Efficace dans toutes les formes de dépression
- Efficacité et vitesse d'action analogues pour les dépressions modérées
- Moins d'effets secondaires
- Moins de ruptures de traitement
- Une fois le traitement terminé effets à long terme et prévention des rechutes
- Mécanismes d'action au niveau cérébral communs et spécifiques

- Indication à l'**hospitalisation**

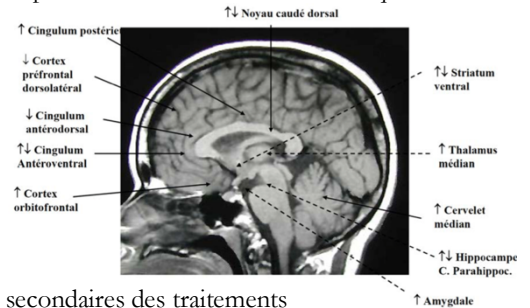
- Suicidalité incontrôlable
- Épisode dépressif sévère avec inhibition ou agitation marqués
- Insomnie sévère et persistante
- Angoisse aiguë et attaques de panique envahissantes
- Problèmes psychosociaux (isolement, âge, surmenage, entourage peu soutenant)
- Dépression réfractaire
- Manie avec risques de passages à l'acte

- **Traitement combiné**

- **Dysthymie**
- **Dépression chronique**
- Traits de caractère et **troubles de la personnalité** (dépendants, borderline et histrioniques)
- Symptômes résiduels
- Risque de rechute
- Alliance et adhérence au traitement
- Acquisition de stratégies de résolution de problèmes
- Problèmes relationnels et avec l'entourage

- Avantages du **traitement combiné**

- Moins de refus de traitement
- Meilleure compliance médicamenteuse
- Taux de réponse et taux de rémission supérieurs

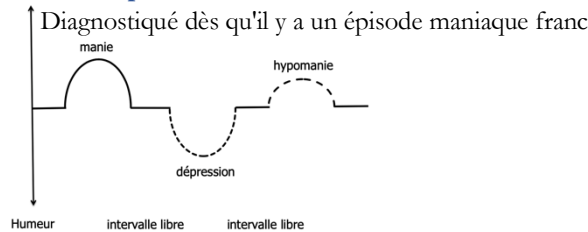


- Choix selon le type de dépression
 - EDM léger à moyen
 - Psychothérapie spécifique
 - AD
 - EDM récurrent
 - Traitement continuation
 - Traitement combiné
 - EDM avec symptômes psychotiques et mélancolie
 - AD et NE
 - ECT
 - Dépressions atypiques
 - AD non tricycliques
 - Dépressions saisonnières
 - Luminothérapie
 - Trouble dysthymique
 - Psychothérapies
 - AD
 - Traitement combiné
 - Dépressions chroniques ou complexes
 - Traitement combiné
- Le traitement de la dépression en médecine de premier recours
 - Avantage de la prise en charge par le généraliste
 - Disponibilité à court terme
 - Relation de confiance
 - Prise en charge globale
 - Pas de stigmatisation psychiatrique
 - Contacts avec la famille et l'entourage
 - Début précoce du traitement
 - Suivi à long terme
 - Écueils possibles de la prise en charge par le généraliste
 - Diagnostic parfois difficile (comorbidité, troubles de la personnalité)
 - Évitement de la confrontation au diagnostic psychiatrique
 - Interprétation psychologisante
 - Disponibilité limitée pour un cadre de type psychothérapique (fréquence et durée des entretiens)
 - Stratégies pharmacologiques limitées
 - Pas de formation aux psychothérapies spécifiques
 - Quand transmettre au psychiatre
 - Diagnostic incertain
 - Dépression avec symptômes psychotiques
 - Dépression bipolaire
 - Dépression chronique
 - Trouble dysthymique
 - Comorbidité troubles somatiques et troubles psychiatriques
 - Suicidalité
 - Résistance au traitement prescrit (4-6 semaines)
 - Intolérance aux effets secondaires
 - Utilité d'une psychothérapie spécifique

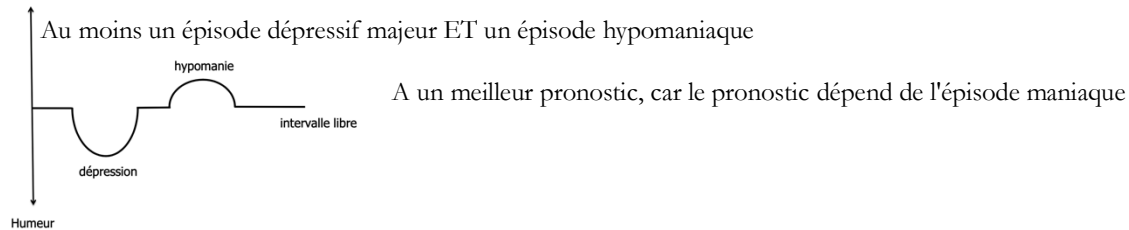
c. Troubles bipolaires

- Les types de troubles bipolaires : pour définir le type, il est utile de tenir un calendrier des épisodes thymiques
 - **La psychose maniaco-dépressive**
 - *Succession* accès maniaques et dépressifs
 - *Anosognosie*
 - *Altération du contact avec la réalité*
 - *Idées délirantes* :
 - Mégalomaniaques
 - Persécutrices
 - De ruine
 - D'indignité
 - D'incurabilité
 - *Hallucinations*

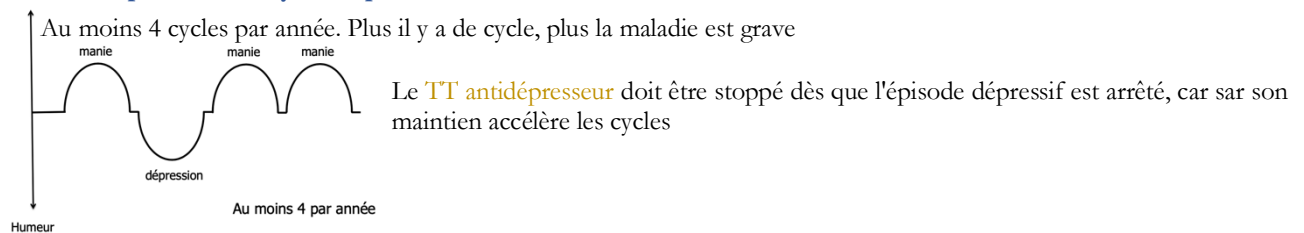
- **Trouble bipolaire 1**



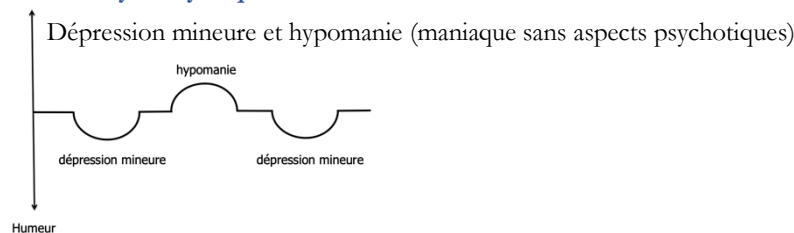
- **Trouble bipolaire 2**



- **Trouble bipolaire avec cycles rapides**



- **Trouble cyclothymique**



- **Trouble schizo affectif**

- Présence de symptômes thymiques et de symptômes schizophréniques
- Spécifications des épisodes maniaques et hypomaniaques
 - Avec cycles rapides
 - Avec détresse anxieuse
 - Avec caractéristiques mélancoliques
 - Avec caractéristiques atypiques
 - Avec caractéristiques mixtes
 - Épisode maniaque ou hypomaniaque + 3 symptômes :
 1. Dysphorie ou humeur dépressive
 2. Diminution de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités
 3. Ralentissement psychomoteur presque tous les jours
 4. Fatigue ou perte d'énergie.
 5. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
 6. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes
 - Avec caractéristiques psychotiques
 - Congruentes à l'humeur
 - Non congruentes à l'humeur
 - Avec catatonie
 - Avec début dans le péri-partum
 - Avec caractéristiques saisonnières

- Le diagnostic

- **Épisode maniaque** DSM-5

- Période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est anormalement élevée, expansive ou irritable
- Augmentation anormale et persistante de l'activité orientée vers un but ou de l'énergie
- Persistant la plupart du temps, presque tous les jours, pendant au moins une semaine (ou toute autre durée si une hospitalisation est nécessaire)
- Au moins 3 des symptômes suivants (4 si seulement irritabilité) :
 1. *Augmentation de l'estime de soi* ou *idées de grandeur*
 2. *Plus grande communicabilité*, désir de parler constamment (*logorrhée*)
 3. *Fuite des idées* (objective ou subjective)
 4. *Distractibilité*

- 5. Réduction du besoin de sommeil
- 6. Engagement excessif dans des activités agréables mais avec des conséquences dommageables (financières, sexuelles)
- 7. Augmentation de l'activité orientée vers un but (social, scolaire, sexuel) ou agitation psychomotrice
- Un **épisode maniaque** complet qui apparaît au cours d'un **traitement antidépresseur** doit conduire à un diagnostic de **trouble bipolaire I**
- Évolution clinique
 - Début typiquement **brutal** avec aggravation rapide
 - Intensité variable : léger, moyen ou sévère
 - Souvent, forme sévère avec **idées délirantes** ou hallucinations +/- congruentes à l'humeur :
 - Relation privilégiée avec Dieu, un personnage public
 - Chargé d'une mission divine
 - Parfois sentiment de persécution (du fait d'un don ou de ses relations)
 - Abus d'alcool ou de drogues souvent associé qui déclenchent, aggravent et prolongent l'épisode
 - Durée variable :
 - 4-8 semaines à plusieurs mois si non traité
 - 80% de rémissions totales si bien traité
- Problèmes diagnostiques
 - Erreurs de diagnostic dans 69 % des cas
 - Diagnostics erronés les plus fréquents
 - **Dépression** (60 %)
 - **Troubles anxieux** (26 %)
 - **Schizophrénie** (18 %)
 - **Trouble de la personnalité limite** ou **antisociale** (17 %)
 - **Abus** d'alcool ou de substance (14 %)
 - 35 % des patients ont attendu 10 ans ou plus avant de recevoir un diagnostic correct de **trouble bipolaire**
- Prédiction d'un **trouble bipolaire**
 - Dépression débutant **avant 20 ans**, accompagnée de :
 - Symptômes psychotiques
 - Antécédents familiaux de trouble bipolaire
 - Hypomanie induite par un médicament
 - Anxiété épisodique
 - Irritabilité
 - Dépression chronique
 - Ralentissement psychomoteur
- **Trouble bipolaire** et **schizophrénie**
 - *Anhédonie* (impossibilité à prendre du plaisir dans des activités habituellement appréciables) VS *athymhormie* (perte de l'élan vital, de la motivation)
 - *Fuite des idées* vs *troubles du cours de la pensée*
 - *Délire de persécution*
 - *Hallucinations*
 - *Cycles rapides*
 - *États mixtes*
 - *Retard mental*
- Évolution
 - Durée variable : 4 semaines à plusieurs mois
 - Fréquence des cycles très variable
 - Rémission totale ou partielle entre les épisodes
 - Cycles rapides : au moins 4 épisodes différents sur 12 mois
 - Maladie très handicapante :
 - Le patient bipolaire passe la moitié de son temps symptomatique, surtout déprimé
 - La moitié ne travaille pas
 - 8-10% de suicide
 - Importance du traitement :
 - 90 % de récurrence si non traité
 - 80% de rémission totale si bien traité
- **DD** des **troubles bipolaires**
 - Cause somatique :
 - Confusion
 - Épilepsie temporale
 - Hyperthyroïdie
 - Hypercorticisme
 - Induit par une substance :
 - Antidépresseurs
 - Corticoïdes
 - Drogues
 - Troubles psychiatriques :
 - **Schizophrénie**

- Trouble schizo-affectif
- Trouble de la personnalité borderline

• Épidémiologie

- Vulnérabilité génétique
- Prévalence :
 - **Type I** : 0.5 à 2.5% de la population générale, aussi fréquent dans **les deux sexes**
 - **Type II** : 0.5 à 5% de la population générale, plus fréquent chez la **femme**
 - **50%** des **dépansions** vues en consultation sont **bipolaires**
- Début possible à tout âge mais habituellement autour de 20 ans (50% avant 20 ans)
- Type du premier épisode (maniaque ou dépressif) variable
- Retard diagnostique de 10 à 15 ans

• Traitement du trouble bipolaire

• Traitement des phases aiguës :

• Épisode dépressif majeur

- **Lithium**
- Lamotrigine
- AD
- Olanzapine/Fluoxétine
- Risque de virage **hypomaniaque** ou **maniaque** :
 - 23% sous placebo
 - 21% sous **lithium**
 - 28% sous **AD tricyclique + lithium**
 - 51% sous **AD tricyclique**
- Risque d'accélération des cycles :
 - 25% des patients présentent une accélération des cycles sous **AD**
 - Facteurs de risques :
 - Femme
 - Jeune
- **ISRS** (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) sont les **AD** de choix chez les patients avec un **trouble bipolaire** :
 - Meilleure tolérance
 - Meilleure compliance
 - Risque de virage (**hypo**)**maniaque** diminué
 - Attention aux interactions médicamenteuses
- Ajouter un **thymorégulateur** (**lithium**, lamotrigine, acide valproïque)

• État maniaque

- Neuroleptiques
- **Lithium**
- Divalproate
- Benzodiazépines (hautes doses)

• Précautions à prendre avec le **Lithium**

- Bilan avant le début du traitement, annuellement par la suite :
 - Électrolytique
 - Cardiaque
 - Rénal
 - Thyroïdien
- Prudence ou arrêt en cas de :
 - Grossesse
 - Utilisation de diurétiques
 - Régime sans sel
 - Déshydratation
 - Fièvre > 38,5°
- Contrôle trimestriel de la lithémie (taux de lithium dans le sang)

• Hospitalisation

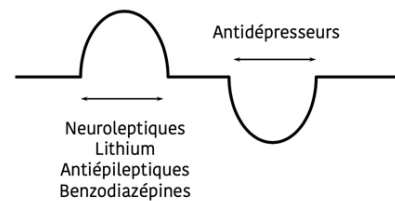
- En raison des risques courus au cours des épisodes maniaques et de l'absence, dans les premiers épisodes au moins, de conscience de la maladie, le recours à une **hospitalisation** d'office est presque toujours nécessaire

• Traitement prophylactique des rechutes

- Médicaments stabilisateurs de l'humeur
 - **Sels de Lithium** (Priadel®, Lithiofor®, Quilonorm®)
 - Valproate (Dépakine®)
 - Carbamazépine (Tégrétol®)
 - Lamotrigine (Lamictal®)

	Prévalence vie entière (%)	Prévalence sur 1 an (%)	Prévalence sur 1 mois (%)
Épisode dépressif Majeur	5-17	3-10	2-7
Trouble dysthymique	3-6	3	3
Trouble dépressif mineur	10	2	-
Trouble dépressif bref récurrent	16	4-8	5
Spectre unipolaire	20-25	10-15	5-10
Trouble bipolaire I	0-2.4	0.9-1.3	0.4-0.5
Trouble Bipolaire II	0.3-4.8	-	-
Cyclothymie	0.5-6.3	0.5-1.4	-
Spectre Bipolaire	2.6-7.8	0.5-1.4	0.4-0.5

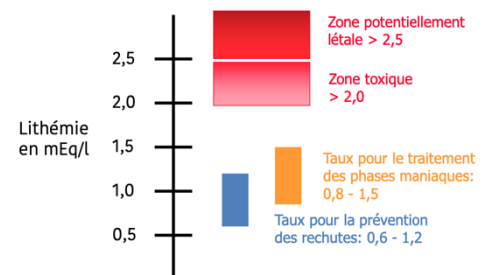
Phases aiguës



Prophylaxie des rechutes

Stabilisateur de l'humeur

Marge thérapeutique du lithium



- **Topiramate** (Topamax®)
 - **Gabapentine** (Neurontin®)
- Aspects non pharmacologiques
 - **Psychoéducation**
 - Première ligne
 - Insight sur la maladie
 - Détection précoce des symptômes prodromaux
 - Adhérence au traitement
 - Prévention des rechutes
 - Prévention du suicide
 - Deuxième ligne
 - Gestion du stress
 - Éviter les abus d'alcool et de drogues
 - Favoriser un style de vie plus normal
 - Troisième ligne
 - Améliorer le contrôle du stress, éviter abus d'alcool et de drogues, stabiliser le mode de vie
 - Faire face aux conséquences psychosociales des épisodes passés et futures
 - Amélioration du fonctionnement entre les épisodes
 - Faire face aux symptômes résiduels subsyndromiques et qui perturbent le fonctionnement
 - Amélioration de la qualité de vie et du bien-être

3) Troubles anxieux

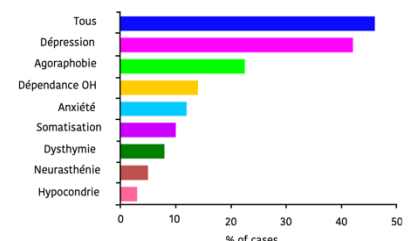
- Craintes et obsessions
 - Préoccupations anxieuses non délirantes qui déterminent parfois le comportement
 - **Phobies** (peur de certaines situations ou objets, qui mènent à des conduites d'évitement)
 - **Obsessions** (idées et représentations qui s'imposent de manière répétée et sont vécues comme absurdes)
 - **Compulsions** (conduites que le sujet accomplit toujours sous la force de contraintes intérieures obsédantes)
- Les différents types d'anxiété
 - Situations de stress de la vie courante
 - Anxiété secondaire à certaines pathologies organiques
 - Composante de certaines maladies psychiatriques :
 - **Dépression**
 - **Schizophrénie**
 - Troubles anxieux spécifiques
 - Anxiété non pathologique
 - Souffrance faible ou supportable
 - Sentiment de contrôle du vécu psychopathologique
 - Capacité de mettre de côté les symptômes temporairement
 - Interférence minime avec la vie quotidienne
 - Lié à un événement que l'on peut considérer comme angoissant pour la majorité des sujets
 - Peu de symptômes physiques
 - Durée limitée

► **DD** : **Dépression** vs **Anxiété**

- Commun
 - *Fatigue, manque d'énergie*
 - *Troubles de la concentration*
 - *Troubles du sommeil*
 - *Troubles de l'appétit*
 - *Plaintes somatiques cardiovasculaires ou digestives*
 - *Irritabilité*
 - *Idéation suicidaire*
- **Dépression**
 - *Humeur dépressive*
 - *Ralentissement psychomoteur*
 - *Anhédonie* (repli sur soi)
 - *Sentiment de désespoir* (helplessness, hopelessness)
 - *Douleurs chroniques*
- **Anxiété**
 - *Anticipation anxieuse* (crainte d'un malheur)
 - *Inhibition* (frein)
 - *Comportement d'évitement*
 - *Dépersonnalisation et déréalisation*
 - *Troubles neurovégétatifs* (panique)
- Relation entre symptômes anxieux et dépressifs :
 - Trouble anxio-dépressif : diagnostic discutable
 - L'anxiété peut être une composante importante de la dépression

- Les troubles anxieux évoluent souvent vers des dépressions, rarement l'inverse
- Si comorbidité vraie, facteur aggravant :
 - Tableaux cliniques plus sévères
 - Taux de suicides plus élevé
 - Chronicité plus importante
 - Autres comorbidités plus fréquentes
 - Réponses thérapeutiques plus mauvaises
- Nosologie des troubles anxieux :
 - **Attaque de panique**
 - Symptômes psychiques
 - *Sensation de malaise ou de peur intense* :
 - Peur de s'évanouir
 - Peur de mourir
 - Peur de perdre le contrôle de ses pensées ou de son comportement
 - Peur de devenir fou
 - Peur de ne pouvoir être secouru
 - *Dépersonnalisation*
 - *Déréalisation*
 - Symptômes psychomoteurs
 - Activation psychomotrice :
 - *Agitation*
 - *Crispation*
 - Crise clastique (crise au cours de laquelle le sujet devient violent et brise des objets)
 - Inhibition :
 - Sidération stuporeuse
 - Symptômes somatiques (90% des patients rapportent exclusivement des plaintes somatiques)
 - *Palpitations, tachycardie*
 - *Sentiment de gêne ou douleur thoracique*
 - *Dyspnée, sentiment d'étouffement, d'étranglement, de souffle coupé*
 - *Tête vide, instabilité, vertige*
 - *Tremblements et secousses musculaires*
 - *Frissons et bouffées de chaleur*
 - *Sudation profuse*
 - *Nausée ou gêne abdominale*
 - *Paresthésie* (trouble du sens du toucher, désagréables mais non douloureux : fourmillements, picotements, engourdissements)
 - Attaque de panique DSM-5
 - Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intenses, dans laquelle au minimum quatre des symptômes suivants sont survenus de façon brutale et ont atteint leur acmé en moins de 10 minutes :
 1. palpitations, battements de cœur ou accélération du rythme cardiaque
 2. transpiration
 3. tremblements ou secousses musculaires
 4. sensation de « souffle coupé » ou impression d'étouffement
 5. sensation d'étranglement
 6. douleur ou gêne thoracique
 7. nausée ou gêne abdominale
 8. sensation de vertige, d'instabilité, de tête vide ou impression d'évanouissement
 9. déréalisation (sentiment d'irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi)
 10. peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou
 11. peur de mourir
 12. paresthésies (sensations d'engourdissement ou de picotements)
 13. frissons ou bouffées de chaleur
 - Types d'attaques de panique
 - Les attaques **inattendues**
 - Les attaques **attendues**
 - Les attaques de paniques peuvent être relevées pour **tous les troubles psychiatriques** (spécificateurs)
 - **Trouble panique**
 - **Attaques de panique** récurrentes et inattendues
 - Au moins un des symptômes qui suit :
 - Crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique ou de leurs conséquences (p.ex. perdre le contrôle, avoir une crise cardiaque, « devenir fou »)
 - Changement de comportement important en relation avec les attaques (comportements d'évitement)

Fréquence attaques panique dans les troubles psychiatriques



- Progression des symptômes dans le trouble panique
 - Phase 1 : attaques spontanées
 - Phase 2 : sensibilisation
 - Phase 3 : trouble panique
 - Phase 4 : évitement menant à l'**agoraphobie**
 - Phase 5 : démoralisation menant à la **dépression**
 - Phase 6 : développement de dépendances

- Complications cliniques

- Évitement-agoraphobie 33%
- Dépression** 50-70%
- Abus de tranquillisants 17%
- Abus d'alcool 27%
- Suicide 20%

- Complications psychosociales

- Rétablissement à 7-9 ans
- Santé physique et mentale
- Fonctionnement social
- Fonctionnement conjugal
- Dépendance financière
- Urgence

- Neurobiologie du trouble panique

- Facteurs familiaux
- Jumeaux univitellins : 31%
- Neurotransmission
- Récepteurs noradrénergiques, sérotoninergiques, GABA, ligands endogènes
- Études de provocation
- Lactate, CO₂, yohimbine, etc...
- Imagerie fonctionnelle
- Hippocampe et région parahippocampique

- Agoraphobie**

- Évitement ou anxiété liée au fait de se retrouver dans deux au moins des situations suivantes :
 - Transports en commun
 - Endroits ouverts
 - Endroits clos
 - File d'attente ou foule
 - Seul à l'extérieur du domicile
- La personne craint ou évite ces situations
 - Parce qu'il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper
 - Ou qu'il ne serait pas possible de trouver de secours en cas de symptômes incapacitants ou embarrassants (panique, chute chez personne âgée ou incontinence)

- Phobie spécifique**

- Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien excessive, déclenchée par la présence ou l'anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique
- L'exposition au stimulus phobogène provoque de façon quasi systématique une réaction anxieuse immédiate qui peut prendre la forme d'une **attaque de panique**
- L'objet ou la situation sont activement évités
- Le sujet reconnaît souvent le caractère excessif ou irrationnel de la peur
- Peurs phobiques (DSM-IV)
 - Type animal
 - Type environnement naturel
 - Type sang - injection - accident
 - Type situationnel
 - Autre type

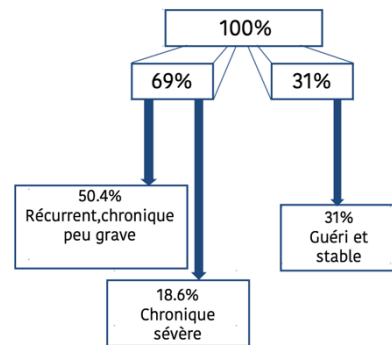
- Anxiété sociale**

- Une peur intense de situations durant lesquelles le sujet est exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui :
 - Interactions sociales
 - Performances
- Le sujet craint d'agir ou de montrer des symptômes anxieux de façon embarrassante ou humiliante
- L'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi systématique une anxiété

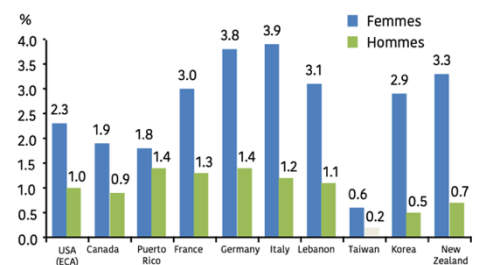
- Anxiété généralisée**

- Anxiété et soucis excessifs et incontrôlables concernant des événements quotidiens (famille, travail, finances...)
- Attente avec appréhension (hypervigilance)
- Présence de 3 symptômes :
 - Agitation*
 - Fatigabilité*
 - Troubles de la concentration et de la mémoire*

Evolution



Trouble panique: prévalence sur la vie entière selon le sexe



DD phobie sociale et agoraphobie		
DD:		
	Phobie sociale	Agoraphobie
Sorties	Seul	Accompagné
Achats	Supermarchés	Petits commerces
Restaurant	Coins reculés	Proche de la sortie
Erythrophobie	Fréquente	Aucune

- Irritabilité
- Tensions musculaires
- Troubles du sommeil
- Troubles fonctionnels

- Anxiété généralisée et soins primaires

- La prévalence de l'anxiété généralisée est sur-représentée chez les médecins de premier recours : 3.7-8.5 %
- L'anxiété généralisée n'est pas toujours correctement diagnostiquée :
 - Aucun diagnostic : 28%
 - Un problème médical : 38% (20% pour la **dépression**)
 - Diagnostic correct : 34% (37% pour la **dépression**)
- La majorité des patients (80%) se plaignent des symptômes somatiques
- Les spécialistes les plus consultés sont les gastroentérologues (côlon irritable)
- Les plaintes cardiaques, les troubles du sommeil et les plaintes douloureuses sont aussi fréquentes
- L'interaction entre troubles somatiques avérés et anxiété généralisée est complexe

- **Trouble obsessionnel compulsif**

- Obsessions

- Pensées ou impulsions récurrentes et persistantes qui sont ressenties comme intrusives et inappropriées
- Plusieurs types :
 - Obsessions **idéatives** : doutes
 - Obsessions **impulsives** (phobie d'impulsion) : actes ou paroles transgressifs
 - Obsessions **phobiques**
- Elles entraînent une anxiété ou une détresse importante
- Le sujet fait des efforts pour les ignorer ou les réprimer ou pour les neutraliser par d'autres pensées ou actions
- Spécifications : qualité de la conscience du trouble (insight) ; présence de tics

- Compulsions

- Comportements répétitifs (lavages, vérifications) ou actes mentaux (prier, compter, répéter des mots silencieusement) que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible
- Les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutée

- Typologie clinique des TOCs

- Les **laveurs** :
 - Obsessions phobiques des saletés, souillures, contaminations
 - Décroissance avec les rituels
- Les **vérificateurs** :
 - Obsessions idéatives
 - Prévenir des catastrophes
 - Peu de décroissance
- Les **ruminateurs** :
 - Phobies d'impulsions
 - Thèmes transgressifs
- **Syndrome de lenteur primaire**
 - Actes courants doivent être accomplis dans un ordre précis
 - Chronophage

► **DD**

- Affections **neurologiques** (chorée de Sydenham, Huntington)
- **Réaction immunitaire** à une infection streptococcique (enfants)
- Trouble de la personnalité obsessionnel-compulsif
- Schizophrénie
- Dépression majeure

- Autres troubles obsessionnels

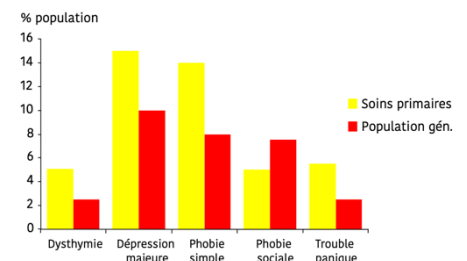
- Obsession d'une dysmorphie corporelle
 - Préoccupation concernant une ou plusieurs imperfections ou défauts perçus dans son apparence physique qui ne sont pas apparents ou qui semblent mineurs pour autrui
 - A un moment de l'évolution du trouble, l'individu a eu des comportements répétitifs (p. ex. vérification dans le miroir, toilettage excessif, excoiration de la peau, recherche de réassurance) ou des actes mentaux (p. ex. comparaison de son apparence avec celle d'autrui) en réponse à des préoccupations concernant son apparence physique
 - Spécifier la qualité de la conscience du trouble

- **Traitement des troubles anxieux**

- **Pharmacothérapie** des troubles anxieux

- **Antidépresseurs**
 - SSRI
 - IMAO réversibles
 - Tricycliques (clomipramine, imipramine)
- **Benzodiazépines** (alprazolam, clonazepam)

Prévalence des troubles psychiatriques



- Anxiolytiques non benzodiazépiniques (buspirone)
- Neuroleptiques
- β -bloquants
- **Thérapies cognitives et comportementales**
 - Indiquées pour : trouble panique, agoraphobie, phobie sociale, phobie spécifique, anxiété généralisée, TOC
 - Analyse comportementale (agenda des angoisses)
 - Exercices idéatoires (thérapie cognitive)
 - Exercices pratiques (exposition)
 - Techniques d'appoint :
 - Relaxation musculaire progressive
 - Biofeedback
 - Désensibilisation systématique
- **Psychothérapies psychanalytiques**
 - Traitement du trouble panique, des phobies spécifiques et de l'anxiété généralisée
 - Pas le traitement en première intention des troubles des TOC et de l'ESPT
 - Distinction névrose de transfert et névrose actuelle
 - Indication moins liée aux symptômes qu'aux caractéristiques du fonctionnement du patient
- Choix selon le type de trouble anxieux
 - Trouble panique
 - Alprazolam, SSRI
 - Psychothérapie spécifique
 - Agoraphobie
 - Psychothérapie spécifique
 - Anxiété généralisée
 - Psychothérapie spécifique
 - SSRI
 - Phobie sociale
 - Psychothérapie spécifique
 - Benzodiazépines, SSRI
 - Phobie spécifique
 - Psychothérapie spécifique
 - TOC
 - Psychothérapie spécifique
 - SSRI
 - ESPT
 - Defusing
 - SSRI
- **État de stress et réactions traumatiques**
 - Traumatismes psychiques se définissent par :
 - Une confrontation avec la mort
 - Une menace par rapport à de l'intégrité psychique et physique
 - Leur soudaineté
 - Leur intensité
 - Un vécu d'impuissance et de contrainte
 - *Réactions de protection immédiate*
 - Le stress :
 - L'éveil physique et psychologique face à une menace ou un changement dans l'environnement
 - La dissociation :
 - La capacité à se déconnecter d'une partie de soi-même lorsque la situation est trop intense
 - **État de stress aigu**
 - Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient présents :
 - Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée
 - La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur
 - *Symptômes état de stress aigu*
 - Remémoration (images, pensées, rêves, illusions, flash-back, reviviscence)
 - Humeur négative
 - Évitement des stimuli qui réveillent la mémoire du traumatisme (pensée, sentiment, conversations, activités, endroits, personnes)
 - Symptômes d'éveil (sommeil, irritabilité, concentration, hyper-vigilance, sursaut, agitation)
 - *Symptômes dissociatifs*
 - Torpeur, détachement, absence de réactivité émotionnelle
 - Réduction de la conscience de son environnement
 - Déréalisation

- Dépersonnalisation
- Amnésie dissociative
- Évolution
 - 11% vers un ESPT
 - 4 **femmes** pour 1 homme
 - Prévalence sur la vie : 8% aux USA et 1-2% en Europe
 - Formes subsyndromiques fréquentes
- **État de stress post-traumatique (ESPT)**
 - *Syndrome de remémoration*
 - Souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement (images, pensées, perceptions)
 - Rêves répétitifs
 - Impression soudaine que l'événement va se reproduire (flashbacks, illusions, hallucinations, épisodes dissociatifs)
 - Détresse psychique lors de l'exposition à des indices évoquant l'événement traumatique
 - Réactivité physiologique dans des situations analogues
 - *Syndrome d'évitement*
 - Effort pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associées au traumatisme
 - Effort pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent le souvenir du traumatisme
 - *Humeur négative*
 - Incapacité de se souvenir d'un aspect important du traumatisme
 - Réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes
 - Sentiment de détachement d'autrui ou bien de devenir étranger aux autres
 - Restriction des affects
 - Sentiment d'avenir bouché
 - *Activation neurovégétative*
 - Troubles du sommeil
 - Irritabilité
 - Difficulté de concentration
 - Hyper-vigilance
 - Réaction de sursaut exagérée
 - Comportement irréfléchi ou autodestructeur
 - **Traitement** des réactions au stress
 - Intervention immédiate : **defusing** (heures qui suivent)
 - Exprimer le vécu immédiat
 - Informer sur les réactions possibles
 - Évaluer la nécessité d'un soutien
 - Intervention dans les jours qui suivent : **debriefing** (jours qui suivent)
 - Permettre aux personnes qui ont vécu un événement en commun de se revoir
 - Mettre les événements dans l'ordre de leur déroulement
 - Laisser la place aussi au vécu
 - Informer sur les réactions possibles
 - Activer les ressources
 - Évaluer la nécessité d'un soutien
 - Contribuer à diminuer les répercussions psychiques possibles
 - Traitement de suivi
 - Éviter les benzodiazépines
 - TCC
 - EMDR
 - SSRI
 - **Troubles de l'adaptation**
 - DSM-5
 - Développement de symptômes
 - En réaction à un ou plusieurs facteur(s) de stress identifiable(s)
 - Au cours des trois mois suivant la survenue de celui-ci (eux-ci)
 - Ces symptômes ou comportements sont cliniquement significatifs, comme en témoignent :
 - Soit une souffrance marquée, plus importante qu'il n'était attendu en réaction à ce facteur de stress
 - Soit une altération significative du fonctionnement social ou professionnel (scolaire)
 - Avec humeur dépressive
 - Avec anxiété
 - Mixte : dépressif et anxieux
 - Avec perturbation des conduites
 - Mixte : conduites et émotions
 - Non spécifié

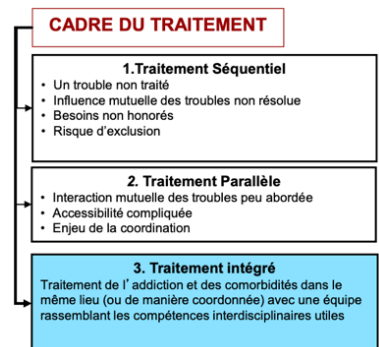
4) Addictions

- Priorisation du comportement de consommation
- 12 mois
- **Perte de contrôle** sur le comportement
 - Stimuli conditionnés
 - Biais attentionnels
 - Facteurs associés aux rechutes
 - Unpleasant emotions
 - Conflict with others
 - Social pressures
- Persiste malgré des **conséquences négatives** (sur soi-même ou sur les autres)
 - Physique (mortalité $\nearrow$ 3-5 SMR)
 - Psychologique (dépendance, troubles mentaux)
 - Social

TABLEAU 2 : INDICATIONS SUR LA SITUATION SOCIALE DES PERSONNES DÉBUTANT UN TRAITEMENT, PAR SUBSTANCE

	Alcool	Opiacés	Cocaïne	Cannabis
Situation de logement stable	90,6 %	67,6 %	76,0 %	90,2 %
Revenus d'activité	49,6 %	25,3 %	43,5 %	27,2 %
Rente (AVS/AI)	15,5 %	15,2 %	11,5 %	5,8 %
Prestations d'aide sociale	16,0 %	40,2 %	23,6 %	11,2 %
Indemnités d'assurance-chômage	6,9 %	5,4 %	5,8 %	2,5 %
Financement par les parents et la famille	2,4 %	3,1 %	5,2 %	50,3 %
Travail à temps complet (> 70 %)	41,5 %	23,5 %	40,7 %	21,3 %
Absence d'activité sur le marché de l'emploi	22,3 %	34,8 %	22,2 %	8,7 %
En cours de formation	2,7 %	1,2 %	4,0 %	50,4 %
Âge moyen en début de traitement	45,3	36,1	31,6	21,8

- **Altération du fonctionnement**
 - **Fréquence des troubles concomitants**
 - Population avec troubles mentaux : **22%** (troubles liés à l'usage de substance -hors tabac- dans l'année)
 - Population avec troubles liés aux substances : **40%** avec trouble mental dans l'année
 - Troubles concomitants $\nearrow$ chez les personnes avec des troubles sévères
 - Risques augmentés
 - $\searrow$ Qualité de vie
 - $\searrow$ Réponse aux traitements
 - $\nearrow$ Fréquence/durée hospitalisations
 - $\nearrow$ Maladies somatiques
 - $\nearrow$ Tentamen
 - $\nearrow$ Exposition aux violences
 - $\nearrow$ Mortalité précoce
 - $\nearrow$ Décès par overdose
 - $\nearrow$ Problèmes juridiques, financiers et sociaux
 - $\nearrow$ Difficultés d'engagement en traitement et Drop-outs
- **Traitements intégrés**
 - Évaluation Intégrée
 - Évaluation complète ("Comprehensive" : addiction, somatique, psychiatrique, sociale)
 - Répondre à leurs besoins immédiats
 - Recherche de besoins multiples (problèmes de santé physique, SDF...)
 - Se souvenir des possibles difficultés d'accès aux services car ils sont stigmatisés
 - Se souvenir que la personne peut avoir une gamme de maladies chroniques
 - Se souvenir que les besoins non satisfaits peuvent les amener à faire une rechute ou affecter leur santé physique
 - Intégration de services interdisciplinaires (Accessibilité, Flexibilité, "Tailored")
 - Répondre aux besoins sociaux



5) Troubles de personnalité (TP)

- Personnes manifestant de la difficulté à gérer les relations avec autrui
- Tendance à répéter des schémas de comportement relationnel qui complexifient la relation :
 - Dépendance excessive à l'autre et sentiment d'abandon
 - Idéalisation puis rejet
 - Tendance à monter les gens les uns contre les autres
- Fréquents comportement ou menaces suicidaires
- Fréquentes comorbidités :
 - Abus de substances
 - Dépendances
 - Dépression
- Définition
 - Modalité de l'expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu
 - Touche l'ensemble du fonctionnement du sujet : cognitif, affectif, comportemental (impulsivité), relationnel
 - Durable, rigide et envahissant
 - Décelable au plus tard à l'adolescence ou au début de l'âge adulte
- Important de le diagnostiquer car :
 - Altère globalement la vie du patient
 - Souffrance diffuse et difficile à mettre en mot
 - Facteur de risque pour les troubles de l'axe I
 - Répercussions marquées sur l'entourage
 - Complique la relation médecin-malade

- **Traitement** long et souvent difficile :
 - **Pharmacothérapie** inutile, hormis pour les comorbidités dépressives et anxieuses
 - **Psychothérapie** au long cours **seul traitement curatif** (entre 4 et 6 ans)
- Tempérament, caractère et personnalité
 - Le **tempérament** ^(biologique) d'un individu, c'est ce que la nature a fait de lui ; son **caractère** ^(histoire) c'est ce que l'histoire a fait de son tempérament ; et sa **personnalité**, c'est ce qu'il a fait, et ne cesse de faire, de ce que la nature et l'histoire ont fait de lui
 - **Tempérament**
 - Disposition générale de l'humeur et de la sensibilité d'un sujet dans sa relation avec lui-même et le milieu extérieur
 - Théorie des tempéraments : 4 tempéraments

Humeur	Sang	Phlegme	Bile jaune	Bile noire
Tempéraments	Sanguin	Lymphatique	Colérique	Mélancolique
Personnalité	Joyeux et actif	Joyeux et passif	Triste et actif	Triste et passif
Éléments	Terre	Air	Feu	Eau
Qualités	Chaud	Froid	Sec	Humide
Organes	Cœur	Cerveau	Faie	Rate
 - Sanguin
 - Lymphatique
 - Colérique
 - Mélancolique
 - **Caractère**
 - Trait propre à une personne (souvent négatifs), à une chose, et qui permet de la distinguer d'une autre
 - **Personnalité**
 - Ce qui fait l'individualité d'une personne morale. Ce qui différencie une personne de toutes les autres
 - L'histoire du **tempérament mélancolique** et de la typologie des caractères manifeste la dimension stigmatisante de cette famille de notions
 - **Caractère** et **personnalité** visant tous deux à exprimer la singularité de chaque individu, la notion de trouble de la personnalité et de toute typologie y relative est a priori équivoque
 - Les premières classifications
- DSM 3 : Problèmes
 - Classification hétérogène
 - Peu de données scientifiques
 - Seuil entre normal et pathologique difficile à apprécier
 - Différences artificielles et arbitraires
 - Stigmatisation
 - Catégories inadéquates :
 - Faible fidélité interjuges
 - Faible stabilité dans le temps
 - Hétérogénéité clinique au sein d'une même catégorie
 - Trouble de la personnalité non spécifié surreprésenté
- DSM 5 et CIM 11
 - Modalités durables de l'expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu. Cette déviation est manifeste dans au moins deux des domaines suivants :
 - La cognition
 - L'affectivité
 - Le fonctionnement interpersonnel
 - Le contrôle des impulsions
 - Ces modalités sont rigides et envahissent des situations personnelles et sociales très diverses
 - Ce mode durable entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants
 - Ce mode est stable et prolongé et ses premières manifestations sont décelables au plus tard à l'adolescence ou au début de l'âge adultes
- Diagnostic et traitement
 - Démarche diagnostique
 - Entretien clinique usuel : (un seul entretien pas suffisant)
 - Fidélité faible
 - Validité faible
 - Instruments standardisés (SCID II) :
 - Fidélité moyenne
 - Validité discutée
 - Entretien de type psychodynamique (conflits intrapsychiques, mécanismes de défense) : (plus utile sur le plan clinique)
 - Fidélité faible
 - Validité bonne
 - Groupe A (**bizarres** et **excentriques**)
 - **Personnalité paranoïaque**
 - Hypertrophie du moi : égocentrisme, surestimation de soi
 - Psychorigide : autoritarisme, ne doute jamais
 - Méfiance : s'attend à ce qu'on l'exploite ou le trompe, doutes de la fidélité des amis/conjoint, ne se confie pas
 - Susceptible
 - Interprétatif, suspicieux
 - Rancunier
 - Fait partie des "troubles du spectre de la schizophrénie"

Troubles de la personnalité DSM IV et 5

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Personnalité schizotypique | A: bizarre |
| ▪ Personnalité schizoïde | |
| ▪ Personnalité paranoïaque | |
| ▪ Personnalité antisociale | B: dramatique |
| ▪ Personnalité borderline | |
| ▪ Personnalité histrionique | |
| ▪ Personnalité narcissique | |
| ▪ Personnalité évitante | C: anxieux |
| ▪ Personnalité dépendante | |
| ▪ Personnalité obsessionnelle-compulsive | |
| ▪ Trouble de la personnalité, non spécifié | |

- Prévalence : 0-4.5%
- **Personnalité schizoïde (hommes ++)**
 - Retrait par rapport aux relations sociales
 - Solitaire, ne cherche ni n'apprécie les relations proches
 - Peu d'intérêt pour les relations sexuelles
 - Pauvreté du registre émotionnel
 - Indifférence aux critiques et aux éloges
 - Peu d'activités qui procurent du plaisir
 - Froideur affective
 - Ne fait probablement pas partie des "troubles du spectre de la schizophrénie"
 - Prévalence : 0-4.1%
 - Plus fréquente chez les hommes
- **Personnalité schizotypique**
 - Gêne dans les relations proches :
 - Anxiété
 - Maladresses
 - Isolement social
 - Distorsions perceptives et cognitives
 - Troubles de la perception
 - Troubles "fins" du discours et de la pensée
 - Croyances bizarres, pensée magique
 - Idées de référence
 - Pauvreté ou inadéquation des affects
 - Conduites excentriques
 - Fait partie des "troubles du spectre de la schizophrénie" ("personnalité pré-morbide")
 - Prévalence : 0-5.6%
 - Considéré comme un "syndrome" dans la CIM-10
- **Prise en charge**
 - Essentiellement **psychothérapeutique**
 - **Neuroleptiques** (atypiques, à faible dose) utile pour la **schizotypie**, parfois pour la **personnalité paranoïaque**
 - **Remédiation** des troubles cognitifs chez les **schizotypes**
- **Groupe B (dramatiques)**
 - **Personnalité antisociale (hommes ++)**
 - Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui :
 - Incapacité à se conformer aux règles et aux normes
 - Tendance à se tromper par profit ou par plaisir
 - Absence de culpabilité
 - Absence d'empathie et de remords
 - Irritabilité et agressivité
 - Incapacité à avoir des relations durables
 - Peut faire suite à un trouble des conduites à l'adolescence
 - Beaucoup plus fréquent chez les hommes
 - Prévalence : 0.2-3.3%
 - Étiologie discutée (génétique, traumatique, abandon, maltraitance)
 - **Traitement** difficile (classiquement considéré comme une contre-indication aux psychothérapies standards)
 - **Personnalité borderline (femmes ++)**
 - Perturbations des émotions :
 - Réactivité marquée de l'humeur
 - Colères intenses inappropriées
 - Sentiments de vide
 - Impulsivité :
 - Gestes ou menaces suicidaires, ou automutilations
 - Addictions
 - Troubles alimentaires
 - Perturbation de l'identité :
 - Instabilité marquée et persistante de l'image de soi
 - Idéation persécutoire
 - Relation interpersonnelles instables et intenses :
 - Idéalisation et dévalorisation
 - Crainte d'abandon
 - Trouble de la personnalité parmi les plus étudiés
 - Prévalence : 0-4.6%
 - Plus fréquent chez les femmes
 - Incidence plus élevée dans les familles avec troubles de l'humeur ou troubles liés à une substance
 - Liens complexes avec les troubles de l'humeur
 - Étiologie discutée (génétique, traumatique, maltraitance)
 - Peut s'améliorer avec les années

- **DD** trouble de la personnalité **borderline** et **dépression majeure**
 - **Dépression sans borderline**
 - Humeur dépressive stable
 - Perte d'intérêt pour l'environnement habituel
 - Sentiment de culpabilité
 - Idées de mort précède et accompagne les tentatives de suicide
 - Fonctionnement stable ou légèrement déprimé entre les épisodes
 - Culpabilité, remords, baisse de l'estime de soi
 - **Dépression et borderline**
 - Brusques variations d'humeur
 - Humeur réactionnelle à des stimuli environnementaux
 - Critiques adressées à autrui
 - Tentatives de suicide impulsives sans idées de mort
 - Fonctionnement instable entre les épisodes
 - Sentiments de solitude, de vide et d'ennui alternant avec des sentiments de rage et de frustrations
- **DD** trouble de la personnalité **borderline** et **trouble bipolaire 2**
 - Retenir qu'il y a un DD à faire et qu'il est difficile
- **Psychothérapie des TPB**
 - Psychothérapie focalisée sur le transfert
 - Thérapie comportementale dialectique
 - Traitement fondé sur la mentalisation
 - Thérapie des schémas
 - Thérapies comportementales et cognitives autres
 - Psychothérapies psychodynamiques autres
- **Personnalité histrionique**
 - Réponses émotionnelles excessives :
 - Manière de parler subjective et pauvre en détails
 - Considère que ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité
 - Quête d'attention :
 - Souhaite être le centre de l'attention d'autrui
 - Dramatisation, théâtralisme et exagération de l'expression émotionnelle
 - Suggestibilité :
 - Facilement influencé par autrui ou par les circonstances
 - **DD** difficile avec **personnalité borderline**
 - Prévalence : 0.3-4.5%
 - Plus fréquent chez les femmes ; donjuanisme chez les hommes
 - Étiologie psychologique : perturbations des relations dans la petite enfance
 - Traitement : **Psychothérapie**
- **Personnalité narcissique**
 - Paradoxe du narcissique :
 - Sens grandiose de sa propre importance fantaisies de succès illimité, pense être spécial et unique
 - Besoin excessif d'être admiré, envie souvent les autres, et croit que les autres l'envient
 - Comportements volontiers arrogants et hautains :
 - Pense que tout lui est dû, exploite l'autre
 - Manque d'empathie
 - Validité du diagnostic discutée
 - Lié surtout à l'approche psychodynamique
 - Caractérise plutôt des traits de caractères ou un problème psychique qu'une véritable pathologie du caractère
 - Prévalence : 0-5.3%
 - Traitement : **Psychothérapie**
- **Groupe C (anxieuses)**
 - **Personnalité évitante**
 - Sentiment de ne jamais être à la hauteur :
 - Se perçoit comme socialement incompetent, sans attrait ou inférieur aux autres
 - Hypersensibilité au jugement d'autrui :
 - Crainte d'être critiqué ou rejeté
 - Inhibition sociale :
 - Timide, effacé, émotif
 - Réticence à s'impliquer avec autrui à moins d'être certain d'être apprécié
 - **DD** : **phobie sociale, personnalité schizoïde**
 - Prévalence : 0-5.2%
 - Apparaît souvent dans l'enfance
 - Traitement : **Psychothérapie**

- **Personnalité dépendante (femmes ++)**
 - Besoin général et excessif d'être pris en charge :
 - A besoin que d'autres assument les responsabilités
 - Difficulté à prendre des décisions seul
 - Comportement soumis et passif :
 - Manque d'initiative
 - A du mal à exprimer un désaccord avec autrui
 - Angoisse de séparation :
 - Lorsqu'une relation proche se termine, chercher de manière urgente une autre relation
 - Prévalence : 0.4-10.3%
 - Plus fréquent chez les femmes
 - Complications : EDM
 - Traitement : Psychothérapie
- **Personnalité obsessionnelle-compulsive (hommes ++)**
 - Besoin excessif d'ordre matériel et moral :
 - Préoccupations pour les règles et l'organisation au point que le but principal de l'activité est perdu de vue
 - Perfectionnisme
 - Entêtement, rigidité :
 - Trop consciencieux et rigide sur des questions de morale
 - Réticence à travailler avec autrui à moins que les autres se soumettent exactement à sa manière de faire les choses
 - Soucis d'économie
 - Tendance aux doutes et aux scrupules :
 - Indécision
 - Prévalence : 0-9.3%
 - Plus fréquent chez les hommes
 - Si véritables obsessions ou compulsions : TOC
 - Complications : EDM, dépendance à l'alcool
 - Traitement : Psychothérapie
- **Trouble de la personnalité non spécifié**
- **Étiologie**
 - Aspects biologiques
 - Vulnérabilité génétique
 - Activité sérotoninergique
 - Aspects relationnels et psychologiques
 - Expérience de séparation et de perte
 - Troubles psychiatriques familiaux
 - Négligence et contrôle excessif
 - Abus sexuels
 - Attachement angoissé ambivalent (type C, 15%)
- **Traitement**
 - Approche personnalisée plutôt que traitement formalisé
 - Alliance thérapeutique essentielle, liée notamment à l'acceptation du diagnostic
 - Définition claire des rôles et des responsabilités : contrat thérapeutique
 - Travail plurimodal en équipe :
 - Psychothérapie
 - Contrat thérapeutique
 - Longue durée
 - Thérapeute actif, flexible
 - Approches groupales concomitantes
 - Hospitalisation(s) si nécessaire
 - Pharmacothérapie
 - Le traitement pharmacologique ne traite pas la pathologie du caractère
 - Traitement des symptômes parallèlement à la psychothérapie
 - Pas de critère d'indication selon le TP, mais uniquement symptomatiques
 - Effets cliniques modestes
 - Durée du traitement définie sur une base clinique (symptômes liés au stress ou à la vulnérabilité caractérielle)
 - Soutien psychosocial
 - Hospitalisations de crise
 - Longue durée (5 ans et plus)

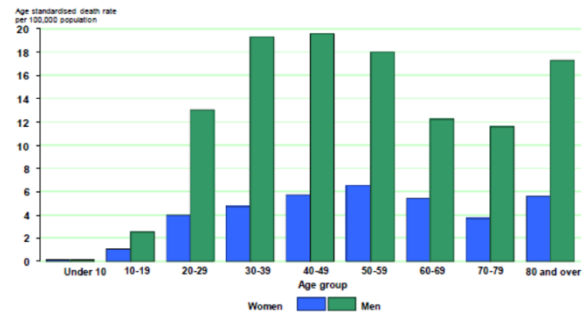
6) Symptômes Comportementaux et Psychologiques associés aux Démences (SCPD)

- Les **symptômes comportementaux et psychologiques de la démence** (SCPD/BPSD) désignent des troubles de la perception, du contenu de la pensée, de l'humeur et du comportement fréquemment observés chez les personnes présentant une démence
- Symptômes psychologique (SCPD)
 - A partir d'un entretien avec le patient et ses proches
 - **États anxieux**
 - Généralisée
 - Phobie
 - Panique
 - Compulsions
 - Godot
 - **Troubles affectifs**
 - *Dépression*
 - *Hypomanie*
 - *Labilité émotionnelle*
 - *Irritabilité*
 - Phénomène psychotiques (nombreux) et perceptifs
 - *Délires* (à ne pas confondre avec délirium) (vol, abandon, infidélité, signe TV, compagnon tardif)
 - *Hallucinations - illusions* (signe miroir, Charles-Bonnet)
 - *Identifications erronées* (Capgras)
 - Changement de personnalité/comportements
 - *Intolérance à la frustration*
 - *Impatience*
 - *Anosognosie*
- Signes comportementaux (SCPD)
 - A partir de l'observation du patient
 - L'*agressivité* physique, verbale
 - *Pleurs et rires* pathologiques
 - Les *vocalisations* : cris, hurlement...
 - *Répétitions* incessantes
 - *Apathie* (! **DD** *dépression*)
 - *Agitation*
 - *Déambulation*, errance, fugues
 - *Comportements inappropriés*, *désinhibition sexuelle*
 - *Syllogomanie* (amasser) - Diogène
 - "Shadowing"
 - *Réactions de catastrophe*
 - *Troubles nyctéméraux*
 - *Troubles alimentaires*
- Prévalence et persistance des **SCPD**
 - Prévalence **communautaire** :
 - Très fréquent : 50% des personnes qui ont une démence développe des SCPD et >90% à 5 ans
 - Persistance sur 18 mois :
 - Délires : 65%
 - Dépression : 58%
 - Comportement moteur aberrant : 55%
 - Prévalence **EMS**
 - Encore **plus que communautaire** !
 - La prévalence des **SCPD** augmente avec le stade de la démence mais n'importe quel type de SCPD peut se retrouver dans n'importe quel type de démence
- Les **SCPD** ont une fréquence ++ et les conséquences sont importantes :
 - ↘ Qualité de vie
 - ↘ Adaptation des patients à leur environnement
 - ↘ Qualité de la prise en charge, exposant au risque de maltraitance ou de négligence
 - ↘ Pronostic fonctionnel de la maladie
 - ↘ Qualité de vie et état de santé physique et psychique des aidants
 - ↗ Troubles somatiques
 - ↗ Mortalité
 - ↗ Prescription médicamenteuse inappropriée
 - ↗ Risque d'hospitalisation et d'entrée en institution
 - ↗ Coût financier
- Apparition et évolution des SCPD est **imprédictible** alors que l'évolution de la perte des fonctions et de la cognition sont prédictibles et plus ou moins parallèle
- Les **SCPD** ne sont pas dues à la démence bien qu'elle soit la condition sine qua none

- Les **SCPD** sont **ultra-fréquents, hétérogènes cliniquement** et **traitable** par des méthodes psychosociales et pharmacothérapie selon l'étiopathogénie, en tenant compte des caractéristiques de la patiente et de son environnement dans le but d'obtenir une meilleure qualité de vie de la patiente et de ses proches aidants

Crise suicidaire

- Suicide en Suisse :
 - 19.1/100'000 habitants
 - Principale cause de mort violente
 - 2^{ème} cause de mortalité chez les 15-20 ans
 - Diminution de 20% de 1992 à 2002
- Différence hommes/femmes :
 - Hommes :
 - Moyens plus violents (pendaison, arme à feu)
 - Plus de suicides
 - Femmes :
 - Moyens moins violents (intoxication)
 - Plus de tentatives de suicides
- Suicide et **troubles psychiatriques**
 - AP :
 - L'Autopsie Psychologique permet de préciser le diagnostic psychiatrique post-mortem en interrogeant les proches, les médecins traitants, et en consultant les dossiers
 - ~90% des patients suicidés présentent une affection psychiatrique
 - **Troubles affectifs**
 - **Dépression unipolaire**
 - >50% des suicidés ont un épisode dépressif
 - 4% des patients dépressifs se suicident
 - Suicide le plus fréquent lors du 1^{er} épisode
 - Traitement antidépresseur : Attention au risque d'**↑** transitoire de la suicidalité !
 - **Trouble bipolaire**
 - 10-15% des patients bipolaires se suicident
 - Le lithium aurait un effet préventif spécifique
 - **Addictions** (abus/dépendance)
 - Alcool
 - 70% des suicides des jeunes adultes font intervenir l'alcool
 - L'alcool **↑** le risque d'agir suite à des impulsions suicidaires
 - Risque suicidaire de 10% chez les alcoolos-dépendant
 - **Schizophrénie**
 - 5% des patients schizophrènes se suicident
 - Souvent lié aux symptômes affectifs de la maladie
 - Facteurs de risques :
 - Mauvaise compliance
 - Abus de substances
 - Précédente(s) tentative(s) de suicide
 - **Troubles de la personnalité**
 - Personnalité émotionnellement labile
 - Personnalité antisociale
 - Formulation psychodynamique :
 - L'agressivité à l'égard d'autrui est retournée contre soi; le geste suicidaire vient "punir" l'autre
- Suicide et santé physique
 - Cancer
 - Maladie infectieuse
 - Douleurs chroniques
 - Maladie de Huntington, SEP, épilepsie
 - Lupus
 - Lésions de la moelle épinière
- Suicide chez la personne âgée
 - **Trouble dépressif**
 - **Dépendance** à l'alcool
 - Troubles cognitifs
 - Affection somatique
 - Deuils
 - Perte d'autonomie
- Suicide et génétique
 - Une histoire familiale de suicide double le risque suicidaire



- Concordance entre jumeaux monozygotes > jumeaux dizygotes
- Gènes candidats : tryptophane hydroxylase, transporteurs à la sérotonine
- Axes de recherche
 - Altération du système sérotoninergique
 - Régulation impulsivité, agressivité, troubles cognitifs (prise de décision)
 - Altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire
 - Régulation du stress
- Stratégie de prévention
 - Prédiction du suicide difficile
 - Les facteurs de risques individuels comptent pour une petite proportion de la variance du risque
 - Chaque personne dépressive devrait être investiguée pour un risque suicidaire
 - On se doit de toujours en parler, d'ouvrir le dialogue, ce qui peut même les soulager
- Évaluation du potentiel suicidaire (RUD)
 - Facteurs de Risques "proximaux"
 - **Précédente tentative**
 - Tentative de Suicide TS = prédicteur le plus important du suicide : 40% des cas
 - 1-6% de suicides dans l'année qui suit une TS
 - TS signe un risque particulièrement élevé chez :
 - Personnes âgées
 - Hommes
 - TS répétées
 - TS avec forte intentionnalité suicidaire
 - Personnes avec abus de substances
 - **Troubles psychiatriques** (90%)
 - Troubles somatiques
 - Crise relationnelle
 - **Crise professionnelle** (40% sans emploi)
 - **Isolement** (45% vivent seul)
 - Accès aux moyens
 - Exposition au suicide (proches, célébrités)
 - Urgence du passage à l'acte
 - Imminence de la conduite suicidaire
 - Degré d'élaboration du scénario suicidaire (où, quand, comment)
 - Intention claire ("Je vais me suicider" - "J'ai repéré le pont...")
 - Planification claire
 - Patient déterminé/coupé de ses affects
 - Dangerosité
 - Accessibilité au moyen envisagé pour le suicide ("J'ai une arme à feu..." vs "Je vais me laisser mourir de faim")
 - Estimation du risque est difficile : peu prédictible
 - Période à risque : semaines après sortie de l'hôpital
- Mesures concrètes à prendre
 - Hospitalisation (volontaire ou PLAF)
 - Si l'évaluation du potentiel suicidaire montre des facteurs de risques, une imminence de passage à l'acte et une dangerosité importante
 - Suivi ambulatoire rapproché
 - Si le risque paraît moins élevé ET qu'une alliance thérapeutique peut se construire avec le patient
 - Retrait de l'accès à certaines méthodes
 - Retrait de certains toxiques
 - Mise de catalyseur sur les voitures
 - Barrière de protection sur les ponts
 - Programmes de prévention ciblé
 - Groupes à risques
 - Prévention scolaire
 - Efficacité établie dans plusieurs pays (GB, CH)
- ▶ Tout médecin devrait pouvoir faire une évaluation du risque suicidaire
- ▶ Évaluation préventive en soi
- ▶ Aborder le sujet, en parler !

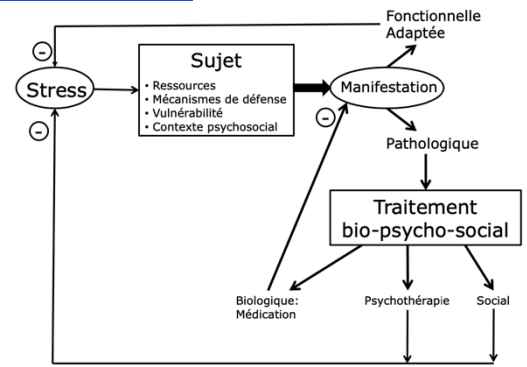
Approches institutionnelles et organisation des soins

Modèle bio-psycho-social

- La prise en charge des troubles psychiatriques graves repose sur le modèle dit "bio-psycho-social", c'est-à-dire sur la mise en œuvre coordonnée de moyens :
 - Biologiques (essentiellement les médicaments)
 - Psychothérapeutique
 - Mesures sociales

Lieux de soin

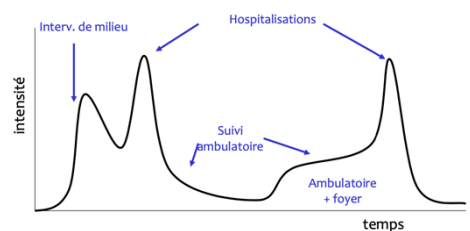
- Psychiatrie à l'ancienne : Modèle asilaire
 - Cohérence
 - Mise à l'abri
 - Aspects néfastes du traitement institutionnel (mise en évidence à la fin des années 60)
 - Stigmatisation
 - Exclusion sociale
 - Induction à la chronicité
 - Parfois mauvais traitements
- Asile remplacé par un vaste **réseau de structures de soins** dans la communauté
 - La prise en charge des pathologies sévères se fait souvent dans divers lieux :
 - Hôpitaux
 - Les traitements hospitaliers tendent de + en + à être brefs (< 3 semaines) et à ne traiter que les aspects aigus
 - Ce qui suppose un renforcement des autres lieux de prise en charge
 - Structures intermédiaires
 - Hôpitaux de jour
 - Ateliers occupationnels
 - Emploi soutenu
 - Foyers, EMS, Appartements protégés
 - Structures ambulatoires
 - Psychiatres installés en privé
 - Médecins généralistes
 - Institutions de psychiatrie publique (souvent mieux à même de prendre en charge des situations lourdes, qui requièrent l'intervention d'infirmiers ou d'assistants sociaux)
 - Intensification de la collaboration entre médecins privés et institutions publiques
 - Psychiatrie communautaire ou « de milieu »
 - Ce type de soins, où les intervenants se déplacent par exemple au domicile des patients, se développe de plus en plus
 - Collaboration avec des institutions existantes (CMS, lieux d'hébergement, etc.)
 - Développement de modes spécifiques d'intervention (auprès des proches p.ex.)
 - Importance de la notion de réseau



Coordination des soins : le réseau

- La chronicité qui caractérise souvent les troubles psychiatriques rend nécessaire la coordination de diverses formes d'intervention thérapeutique ou d'encadrement
- Cette collaboration nécessite donc un travail :
 - En équipe (collaboration pluridisciplinaire à l'intérieur de l'institution de soins);
 - En réseau (collaboration avec des intervenants externes à l'institution)
- Partenaires fréquents de réseau :
 - Médecins généralistes et autres somaticiens, psychiatres installés ou avec des compétences spécifiques
 - Services infirmiers et sociaux de soins communautaires (CMS)
 - Personnel de foyers protégés et d'EMS
 - Éducateurs (en institution ou « de rue »)
 - Personnel d'ateliers protégés, employeurs
 - Organes de l'Assurance-Invalidité
 - Justice de paix, offices de tutelle, tuteurs et curateurs
 - Police
 - Justice pénale et service pénitentiaire
 - Associations d'usagers ou de proches
 - Famille, représentant thérapeutique

Evolution longitudinale des troubles psychiatriques chroniques



La psychiatrie : un monde en mouvement

- Les modifications en cours dans la prise en charge publique des troubles psychiatriques chroniques :
 - Diminution marquée de la durée des séjours hospitaliers
 - Rôle accru des réseaux de soins communautaires
 - De façon générale accentuation du côté « soins » au détriment du côté « contrôle social »

Traitement non-volontaire

- Prise en charge non volontaire
 - La plupart des traitements en psychiatrie sont suivis volontairement par les patients
 - Il y a cependant (et c'est une spécificité de la psychiatrie) un certain nombre de situations où la prise en charge se fait sous contrainte. La relation médecin-malade en est modifiée, et cette modification doit être abordée clairement avec le patient
 - Hôpital de Cery : 35% des admissions se font en PLAFA médical et 8% en PLAFA par la Justice de Paix
- Prises en charge imposées
 - Privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA ; régie par le **Code Civil** ; décision de la **Justice de Paix**)
 - PLAFA médical
 - PLAFA Justice de Paix (PLAFA civil)
 - Traitements imposés par la **Justice pénale** (« mesures », décrites dans le **Code Pénal**, en complément ou en substitution de la peine)
- ▶ **PLAFA MEDICAL**
 - ▶ Décision :
 - ▶ Peut être ordonné par les médecins de premier recours: médecins généralistes et internistes, psychiatres et pédiatres (ou tout médecin travaillant pour un service de garde d'urgence)
 - ▶ Décision peut aussi être prise par le médecin délégué (nombre limité par canton, nommés par le médecin cantonal): personne par laquelle on passe si on ne fait pas partie des médecins de premier recours et qu'on doit hospitaliser un patient)
 - ▶ Basée sur la notion de risque imminent pour lui-même ou les autres ou pour dégradation grave de la situation sociale (état d'abandon)
 - ▶ Durée : Valable au maximum 6 semaines
 - ▶ Avant 6 semaines, le médecin responsable du lieu de soin peut demander la prolongation au delà de 6 semaines pour raisons psychiatriques
 - ▶ A 6 semaines, la mesure doit être levée
 - ▶ Opposition : le patient peut s'opposer à la mesure
 - ▶ Écrit une lettre au Juge de paix dans les 10 jours
 - ▶ Décision doit être prise par JDP dans les 5 jours sur base d'expertise
- La Loi sur la santé publique dans le Canton de Vaud a introduit deux nouveautés importantes pour la psychiatrie :
 - Les directives anticipées
 - Le rôle du « représentant thérapeutique »
 - Depuis janvier 2013 : Traitement ordonné dans la communauté

Les psychothérapies

Pas très important

- Facteurs communs au XIX^{ème} siècle
 - Les troubles psychiatriques sont des phénomènes psychiques
 - Il est essentiel de nouer une relation thérapeutique
 - Cette relation est spécifiquement basée sur la parole
 - La participation active du sujet au traitement est requise
 - La psychothérapie comporte une exigence de vérité à l'égard de soi-même
- Les écoles de psychothérapie (reconnues par la FMH et la FSP)
 - **Psychothérapies psychanalytiques**
 - Conceptions étiologiques
 - Conflits intrapsychiques inconscients déterminés par le passé infantile
 - Buts thérapeutiques
 - Résolution des conflits inconscients par la prise de conscience ; traitement à visée curative
 - Cadre
 - Nombreux dispositifs : en général durée et fréquence des séances fixes
 - Associations libres et abstinence
 - Technique
 - Attention flottante, neutralité bienveillante, interprétations des conflits et du transfert
 - Rôle du thérapeute
 - Disponibilité et présence maximum en évitant le plus possible de prendre parti dans les conflits
 - Durée du traitement
 - Variable : 4 séances, brèves 30-40 séances, longues
 - Prototype
 - Les rêves du patient sont activement discutés
 - Le thérapeute est neutre, il ne prend pas parti face aux conflits exprimés par le patient
 - Le thérapeute pointe l'utilisation par le patient de mécanismes qui le protègent de la souffrance
 - Le thérapeute établit des liens entre la relation thérapeutique et d'autres relations
 - Le thérapeute est attentif aux émotions du patient et se montre activement empathique
 - Le thérapeute interprète des désirs, des sentiments ou des idées réprimés ou dont le patient ne serait pas toujours conscient
 - Le thérapeute explore les idées et les sentiments du patient sans donner son avis ou donner de conseil (attitude d'acceptation sans jugement)
 - Le patient montre une nouvelle compréhension de ses difficultés

- La relation entre le patient et le thérapeute est un sujet explicite de discussion
 - Le thérapeute communique avec le patient dans un style clair et cohérent
- Psychothérapies cognitives et comportementales**
 - Conceptions étiologiques
 - Apprentissage dysfonctionnel déterminé par la relation entre la personne et son milieu
 - Buts thérapeutiques
 - Mise en évidence des distorsions dans les cognitions, les émotions et le comportement ; restructuration
 - Cadre
 - Séances de durée variable, parfois longues ; nombre limité de séances
 - Technique
 - Restructuration cognitive, désensibilisation, renforcement, jeu de rôle
 - Rôle du thérapeute
 - Rôle d'expert, dialogue socratique, conseils, exercices pratiques
 - Durée du traitement
 - Variable : limité dans le temps (10-20 séances), booster sessions, longues (tr de la personnalité)
 - Prototype
 - Le thérapeute propose des tâches ou des activités spécifiques que le patient doit effectuer entre les séances
 - La discussion se focalise sur des sujets bien définis
 - Les buts du traitement pour le patient sont explicitement discutés
 - Le thérapeute encourage le patient à essayer de nouvelles manières de se comporter avec les autres
 - Le thérapeute exerce un contrôle actif sur l'interaction, par exemple en structurant la séance ou en introduisant de nouveaux sujets de discussion
 - Le thérapeute adopte une attitude soutenante
 - Le thérapeute et le patient discute de thèmes précis en lien avec les symptômes du patient
 - Le thérapeute demande au patient plus d'informations et de réflexions par rapport aux questions évoquées
 - La situation de vie actuelle ou récente du patient est mise en avant dans la discussion
 - Le thérapeute donne des conseils explicites
 - Psychothérapies systémiques**
 - Conceptions étiologiques
 - Structures de communication inadéquates déterminées par le contexte familial
 - Buts thérapeutiques
 - Dépistage et modification des structures dysfonctionnelles pour une communication fonctionnelle
 - Cadre
 - Séances de durée assez longue (1h30) ; bilan en fin de séance fréquent
 - Technique
 - Tours de paroles, questions, jeux de rôles, métaphores, recadrages, paradoxes thérapeutiques
 - Observateur actif (miroir sans tain)
 - Rôle du thérapeute
 - Observe, puis décrit et intervient sur la structure de communication dans le système
 - Durée du traitement
 - Contrat limité dans le temps, parfois reconduit de séance en séance
 - Prototype
 - Les relations du patient avec sa famille et son entourage sont au premier plan des thèmes abordés dans les séances
 - Le thérapeute attire l'attention du patient sur son comportement non-verbal, par exemple sa posture corporelle ou ses gestes
 - Le thérapeute identifie des thèmes récurrents dans les relations du patient avec son entourage et sa famille
 - Le thérapeute fait des interprétations qui se réfèrent à des personnes concrètes de la vie du patient
 - Le thérapeute suggère le sens que peut avoir le comportement des personnes avec qui le patient est en relation
 - Le thérapeute s'intéresse aux liens conjugaux, parentaux et filiaux du patient
 - Le thérapeute et le patient accordent de l'importance aux liens familiaux
 - Le thérapeute élabore des hypothèses basées sur la réalité des relations avec la famille et avec les personnes significatives de l'entourage
 - Le thérapeute accorde son attention aux événements marquants de la vie familiale à travers les générations
 - Le thérapeute questionne le patient sur les représentations et les valeurs des membres de sa famille
 - La Loi sur l'Assurance Maladie (LAMaL)
 - Les psychothérapies sont remboursées si on traite des maladies (pas pour le développement personnel) et à condition que les prestations soient efficaces, appropriées, économiques. Il existe un contrôle de qualité de plus en plus présent
 - Efficacité et courbe dose-effet :
 - Les psychothérapies sont des traitements efficaces en psychiatrie
 - La psychothérapie n'est pas toujours positive et son indication doit être réfléchie car avec une psychothérapie :
 - 70% des patients vont mieux
 - 20-25% restent inchangés
 - 5-10% vont plus mal
 - Il n'y a pas de différence notable entre les écoles : paradoxe de l'équivalence ou Dodoo bird effect
 - Elles agissent sur les symptômes et sur le fonctionnement général
 - Elles profitent rapidement à beaucoup de patients (proportion de répondants)

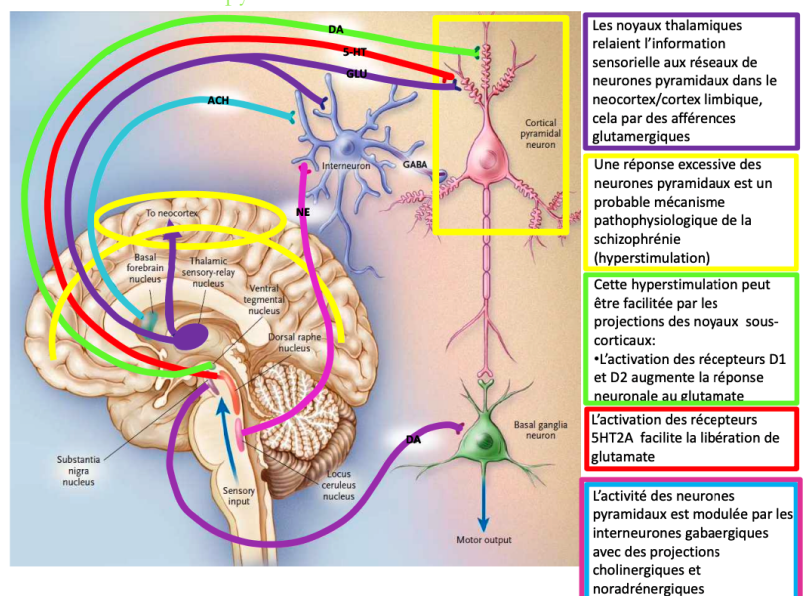
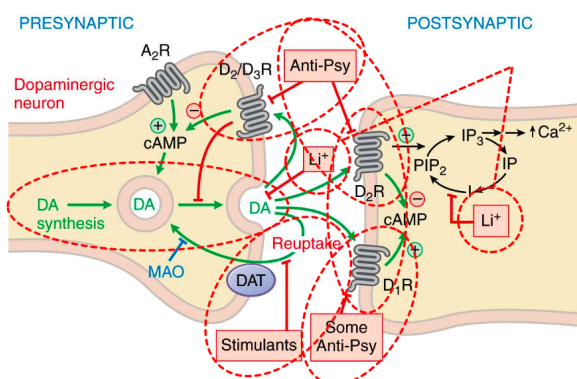
- ▶ Après 4 séances : ~18% sont guéris
- ▶ Après 12 séances : ~40% sont guéris
- ▶ Après 35 séances : ~64% sont guéris
- ▶ Mais l'évolution d'un seul patient est linéaire
- ▶ Des psychothérapies longues sont nécessaires pour certains patients ; leur effet semble supérieur (taille d'effet)
- ▶ Les effets se poursuivent au-delà du traitement : effet retardé, delayed effect
- Neuroimagerie
 - **Fluoxétine** et placebo :
 - Activité commune sur le plan cortical, limbique et para-limbique
 - Pour la fluoxétine activité spécifique au niveau du tronc cérébral, de l'hippocampe, de l'insula et du noyau caudé
 - **TCC** :
 - Activité spécifique au niveau dorsolatéral et medio frontal ainsi qu'un niveau de l'hippocampe
- ▶ La recherche démontre que les psychothérapies sont efficaces pour un ensemble de trouble mentaux, chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée et pour un large spectre de populations
- ▶ Des études multi-sites et des méta analyse ont démontré que les psychothérapies réduisent l'invalidité, la morbidité et la mortalité ; améliorent le fonctionnement professionnel ; et diminuent les hospitalisations psychiatriques
- ▶ Les psychothérapies permettent au patient d'acquérir des compétences qui se maintiennent bien au-delà de la fin du traitement
- ▶ La plupart des clients souffrant de difficultés telles que les troubles anxieux et dépressifs retrouvent le fonctionnement qui correspond aux personnes en bonne santé dans une population générale
- ▶ La très grande majorité des psychothérapies structurées ont une efficacité équivalente
- ▶ L'effet moyen des psychothérapies est supérieur à l'effet de beaucoup de traitements médicaux
- ▶ Les effets des psychothérapies sont souvent comparables ou meilleurs que les effets produits par les traitements médicamenteux pour le même trouble ; et sans les effets secondaires associé à ceux-ci
- ▶ Les effets des psychothérapies tendent à durer plus longtemps que les effets des médicaments
- ▶ Alors qu'une médication est appropriée dans certaines circonstances, la recherche montre que la combinaison de médicaments et de psychothérapie est souvent plus efficace dans le traitement de la dépression et des troubles anxieux

Traitement médicamenteux

Antipsychotiques

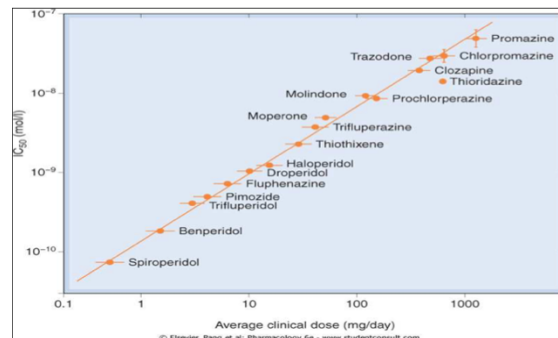
- Les **noyaux thalamiques** relaient l'information sensorielle aux réseaux de **neurones pyramidaux** dans le **néocortex** et le **cortex limbique**, et cela par des **afférences glutamatergiques**
- Une réponse excessive des **neurones pyramidaux** est un probable mécanisme pathophysiologique de la **schizophrénie**
 - Cette hyperstimulation peut être facilitée par les **projections** des **noyaux sous-corticaux** ; l'activation des **récepteurs D1 et D2** augmente la réponse neuronale au glutamate
 - Ensuite, l'activation des **récepteurs 5-HT2A** facilite la libération de **glutamate**
 - Finalement, l'activation des **neurones pyramidaux** est modulée par les **interneurones GABAergiques** avec des **projections cholinergiques** et **noradrénergiques**
- Certaines **substances psychoactives** peuvent entraîner des **syndromes psychotiques**
 - La **cocaïne** est un agoniste **dopaminergique**, donc entrainer une hyperexcitation des **neurones pyramidaux** ; c'est également un agoniste **noradrénergique**, qui favorise donc la libération de **glutamate**
 - Le **LSD** est un agoniste **sérotoninergique** qui favorise la libération de **glutamate**, et l'**atropine** est un **anticholinergique** qui module l'activité des **interneurones**, ce qui augmente l'excitabilité des **neurones pyramidaux**

Rappel neurophysiologique Un des mécanismes pour les symptômes psychotiques: **hyperactivité dopaminergique**

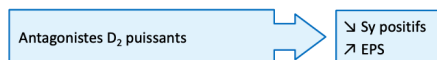


► Indications :

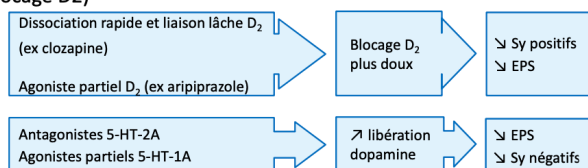
- Psychoses aiguës ou chroniques
- La schizophrénie
- Les manies (troubles bipolaires)
- Les épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires
- Les états d'agitation psychomotrice / comportements agressifs
- Certaines substances sont **antiémétiques**, comme le **droperidole** et le **metoclopramide**
- Il faut savoir qu'un des mécanismes pour les **symptômes psychotiques** est l'**hyperactivité dopaminergique**, avec une augmentation de la concentration de **dopamine** au niveau de la **synapse**. Cette **dopamine** va agir sur les **récepteur D1 ou D2 post-synaptiques**, et tous les **antipsychotiques** sont des **antagonistes** de ces **récepteurs** (peuvent également bloquer la synthèse ou la libération de **dopamine** en présynaptique)
- Dans le **traitement** de la **schizophrénie** par ces **antipsychotiques**, la posologie, le choix du médicament et la voie d'administration dépendent de plusieurs facteurs :
 - Diagnostic et symptomatologie
 - **Efficacité** (tous efficaces puisque autorisation mais certains plus efficaces que d'autres)
 - **Effets secondaires** et sensibilité du patient à ces effets
 - Interactions médicamenteuses (métabolisme par CYP450)
 - **Pas de biomarqueurs** pouvant prédire la réponse au traitement
- On a une bonne corrélation entre la dose clinique d'**antipsychotique** et l'affinité pour le **récepteur D2**
- Tous les **antipsychotiques** actuellement sur le marché sont des **antagonistes** ou **agonistes partiels** des **récepteurs D2**



• AP classiques (première génération)



• AP atypiques (deuxième génération, plusieurs mécanismes en plus d'un blocage D2)



Les antipsychotiques



- **Typiques (classiques)**

- **"incisifs"**

- Ce sont principalement des antagonistes du récepteurs D2
 - Ont pour lui une forte affinité et que l'on utilise donc à petite dose
 - Bonne efficacité contre les *symptômes positifs*
 - Hallucinations
 - Idées délirantes
 - Troubles de la pensée
 - Troubles du comportement
 - Peu efficaces contre les *symptômes négatifs*
 - Repli affectif
 - Diminution des capacités de penser, de parler, d'agir, des réactions émotionnelles
 - Risque d'effets extrapyramidaux
 - Parkinsonisme / Syndrome de Parkinson
 - Akinésie
 - Tremblement
 - Rigidité
 - Dyskinésies tardives
 - Dystonie
 - Acathisie (ne tient plus en place)

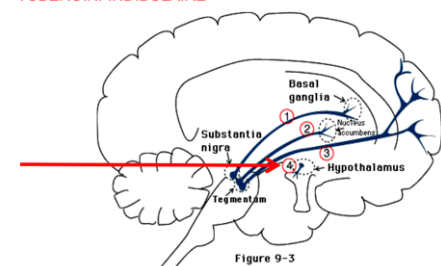
- **"sédatifs"**

- Habituellement, à haute dose
 - Antagonistes des récepteurs D2, mais aussi d'autres récepteurs :
 - Histaminergiques H1 (sédation)
 - Cholinergiques (constipation)
 - Adrénargiques (hypotension orthostatique)
 - Utiles pour la sédation, et sont utilisés parfois en association avec un **incisifs**, chez les patients vraiment agités
 - Les effets indésirables fréquents des **sédatifs** sont
 - Une sédation via H1 (mais peut être l'effet recherché !)
 - Une action anti-cholinergique
 - Déficit de l'accommodation
 - Constipation
 - Rétention urinaire
 - Une action anti-adrénargique
 - Hypotension orthostatique
 - Un effet métabolique
 - Prise de poids (H1 et multiples autres récepteurs)
 - Une hyperglycémie

- **Effets indésirables** fréquents associés à tous les **antipsychotiques typiques (incisifs et sédatifs)**

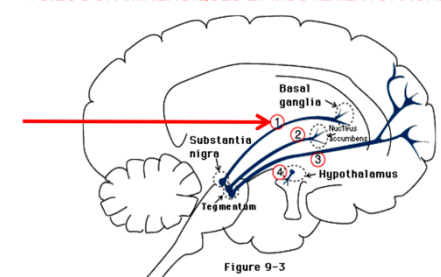
- Une **hyperprolactinémie**
 - Aménorrhée
 - Gynécomastie
 - Galactorrhée
 - Des effets extrapyramidaux
 - Syndrome de Parkinson très fréquents (>10% des patients)
 - Akinésie
 - Tremblement
 - Rigidité
 - **Dyskinésies tardives** (mouvement anormaux bouche, extrémités, tronc) après le traitement prolongé (6 mois de thérapies chez 10-20% des patients), qui peuvent persister même après l'arrêt du traitement (**dyskinésies tardives irréversibles**). Fréquence dépend de la dose et des types de dyskinésies. 5-40% de rémissions
 - Dystonie
 - Acathisie (ne tient plus en place)
 - Le **syndrome malin des neuroleptiques** (rare mais plus fréquent avec les typiques que les atypiques) est caractérisé par :
 - Une **hyperthermie**
 - Une **rigidité musculaire**
 - Des **troubles neurovégétatifs**
 - Une **altération de l'état de conscience**
 - Peut conduire à un **décès** dans ~10% des cas
 - Voie dopaminergique et mouvements anormaux
 - Normalement, la dopamine bloque la libération d'Ach à partir des neurones cholinergiques post-synaptiques au niveau de la voie nigrostriée (connexions entre neurones dopaminergiques et cholinergiques)

HYPERPROLACTINEMIE ET VOIE DOPAMINERGIQUE TUBEROINDIBULAIRE



Voie dopaminergique tuberoinfundibulaire (4): projection depuis l'hypothalamus sur la glande hypophysaire: régule la sécrétion de prolactine (dopamine inhibiteur libération de la prolactine, inhibiteurs de la dopamine augmentent libération prolactine (voie généralement normale chez les patients schizophrènes)

VOIES DOPAMINERGQUES ET MOUVEMENTS ANORMAUX



Voie dopaminergique nigrostriée (1): projection depuis la substance noire vers le ganglion basal (contrôle les mouvements).
Déficiência dopamine: parkinsonisme avec tremblements, rigidité, akinésie...
Excès dopamine (mécanisme compensatoire après blocage récepteur D2: mouvements hyperkinétiques tels que les tics ou dyskinésies.
Chez les schizophrènes non-traités: voie nigrostriée généralement normale.

- Avec un antagoniste dopaminergique (comme un antipsychotique) : ↗ libération d'Ach, ce qui entraîne les mouvements anormaux.
- Antipsychotiques avec activité anticholinergique comme la **clozapine** ou l'**olanzapine** produisent moins d'EPS
- Sinon, **adjonction d'anticholinergiques** pour ↘ EPS du type parkinsonien qui sont du type hypokinétiques (akinésie, rigidité, bradykinésie, tremor, dystonie aiguë) mais pas pour les dyskinésies tardives qui sont du type hyperkinétiques)

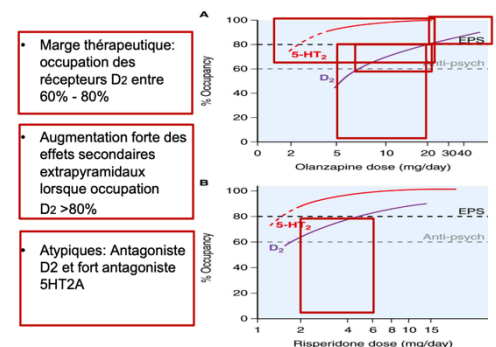
► Limites des neuroleptiques classiques/typiques :

- Effet insuffisant sur les symptômes négatifs et cognitifs
- **Effets secondaires**
 - Effets extrapyramidaux
 - Hyperprolactinémie
 - Problèmes cognitifs
 - Système cardio-vasculaires (prolongation du QT)

• **Atypiques**

- Tous des **antagonistes D2** (sauf **aripiprazole** qui est un agoniste partiel)
- Presque tous **antagonistes 5HT2A** (sauf **amisulpride**, action en présynaptique sur D2/D3)
 - ↘ Effets extrapyramidaux
 - ↗ Efficacité sur les symptômes négatifs
- Plus efficace, cependant toujours modérée contre les symptômes négatifs
- Incidence diminuée d'effet extrapyramidaux et risque diminué de dyskinésie tardive
 - Ils sont donc un **premier choix de prescription**
- Efficacité chez des patients résistants aux antipsychotiques(**clozapine**) (nombreux mécanismes d'action, donc plus efficace mais avec beaucoup d'effets secondaires)
- Globalement **plus à risque de prise de poids** que les typiques
- **Effets indésirables**
 - La **clozapine** entraîne
 - Une **somnolence**
 - Une **hypotension**
 - Un effet **antimuscarinique**
 - Des troubles métaboliques
 - **Prise de poids +++**
 - Une **hyperglycémie**
 - Une **hypertrigly/cholestérolémie**
 - **Toxicité : agranulocytose** dans ~1-2% des cas → contrôles hématologiques sont donc obligatoires
 - **Pas un premier choix, seulement si échec et/ou intolérance à au moins deux autres TT**
 - L'**olanzapine**
 - **Même effets secondaires** mais moins efficace
 - **Pas d'agranulocytose**
 - La **rispéridone** entraîne
 - Une **hypotension**
 - Une **vision trouble**
 - Des **troubles de concentration**
 - Une **prise de poids**, mais moins importante que les cas ci-dessus
 - L'**amisulpride**
 - A des **effets secondaires extrapyramidaux**
 - Peut entraîner une **hyperprolactinémie**
 - Ainsi que des troubles métaboliques avec une légère **prise de poids**
- **Marge thérapeutique :**
 - Occupation des récepteurs D2 entre 60 et 80%
 - ↗ forte des **effets secondaires extrapyramidaux** lorsque occupation D2 >80%

Relation entre l'occupation des récepteurs D2 et l'effet clinique



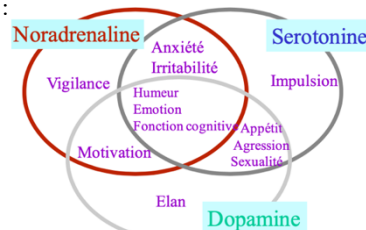
Antidépresseurs

► Indication :

- La **dépression**
- Les **troubles anxieux**
- Les **troubles paniques**
- Les **TOC**
- Principe : ↗ de la neurotransmission **mono-aminergique** (NA, 5-HT, dopamine)
- Apparition de l'effet antidépresseur **après 2 semaines** environ
 - CAVE : tendances suicidaires dans les premières semaines, surtout avec les **tricycliques** qui sont très toxiques en surdosage
- Mécanismes possibles :
- TT par **antidépresseur sérotoninergique** : blocage du transporteur, ↗ de la concentration de **sérotonine** synaptique → activation du récepteur présynaptique, ce qui ↘ sa libération ; on a donc :
 - A court terme une ↘ des concentrations de **sérotonine**
 - Après deux semaines, on a une **down-regulation** ou **désensibilisation** des récepteurs présynaptiques
 - ↗ Libération des **mono-amines**
 - Deux semaines = temps nécessaire pour cette down-régulation, contribue au **délai d'action** des antidépresseurs

- Fonctions attribuées au mono-amines :

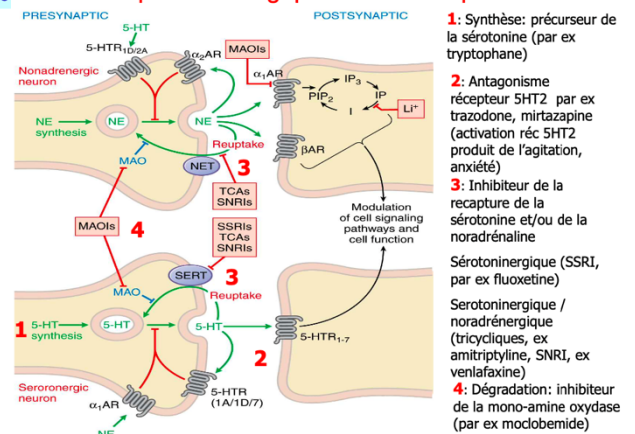
- **Noradrénaline (NA)**
 - Vigilance
- **Dopamine**
 - Élan
- **Sérotonine (5-HT)**
 - Impulsion



- Plusieurs cibles pharmacologiques :

- Synthèse : **précurseur** de la **sérotonine**
 - **Tryptophane**
- **Antagonisme** récepteur 5HT2
 - **Trazodone**
 - **Miansérine**
- **Inhibiteurs** de la recapture de la **sérotonine** :
 - **SSRI** : **Fluoxétine**
- **Inhibiteurs** de la recapture de la **sérotonine** et de la **NA** :
 - **Tricycliques** : **Amitriptyline**
 - **SNRI** : **Venlafaxine**
- **Inhibiteurs** de la recapture de la **dopamine** et de la **NA** :
 - **Bupropion**
- Dégradation : **inhibiteurs** de la MAO (mono-amine oxydase)
 - **MAOI** : **Moclobemide**

Cibles pharmacologiques des antidépresseurs



- Le système **5-HT** est impliqué dans la **dépression** :

- ↓ de 5-HIAA (5-hydroxyindolacetic acid) (produit de dégradation de la **sérotonine**) dans le LCR des patients déprimés
- ↓ de liaison au **récepteur** de la **sérotonine** dans les plaquettes et tissus post-mortem
- Les **antidépresseurs** ↗ le **5-HT** intrasynaptique
 - ↗ libération (**lithium**)
 - ↓ recapture (**SSRI**)
 - ↓ métabolisme (**MAOI**)
 - Antagoniste récepteurs **5-HT** (**Trazodone**, **Miansérine**)
 - Déplétion du précurseur de la **sérotonine** (**Tryptophane**) on constate une rechute chez les patients traités

► Mais la **sérotonine** n'explique pas tout

- Le **BDNF** (Brain-derived Neurotrophic Factor) est impliqué dans la plasticité neuronale (dendrites, synapses) et l'hypothèse est que dans la **dépression**, on a une down-régulation de ce facteur (↓ dans le sérum des patients déprimés), et donc une perte des connexions synaptiques, qui devraient être rétablie par le **TT** antidépresseur

- **TT** antidépresseur : ↗ le **BDNF**, qui est le messager final, ce qui va entraîner une augmentation de l'action trophique (rétablissement des connexions synaptiques), de la survie des neurones et de leur fonction

- Au cours de la **dépression**, on constate une ↗ de l'activité **cérébrale** dans :

- Cortex frontal médian
- Amygdale
- Cortex cingulaire subgénéral (CG25)
 - États de **tristesse transitoire** : ↗ activité
 - **Fluoxétine** dans **dépression chronique** : ↓ activité
 - **Fluoxétine** dans **dépression liée à Parkinson** : ↓ activité
 - **Placebo** : ↓ activité
 - Activité de base permet parfois de prédire le traitement
 - Activité ↓ chez bon réponders dans **phobie sociale**

- Classification

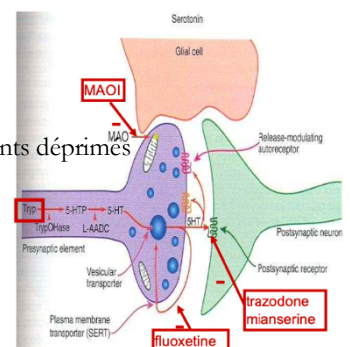
- **Tricycliques** (**Imipramine** (Tofranil®), **Amitriptyline** (Saroten®), **Clomipramine** (Anafranil®))

- Mécanismes :

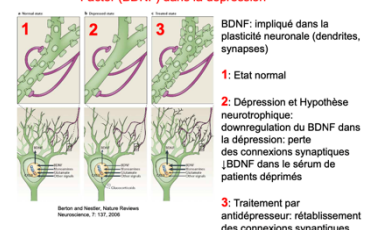
- Inhibition de la recapture des monoamines NA et 5-HT
- Interaction avec plusieurs récepteurs (muscariniques, alpha1-adrénériques, histaminiques)
- Interactions avec des canaux sodiques et autres

- **Effets indésirables** :

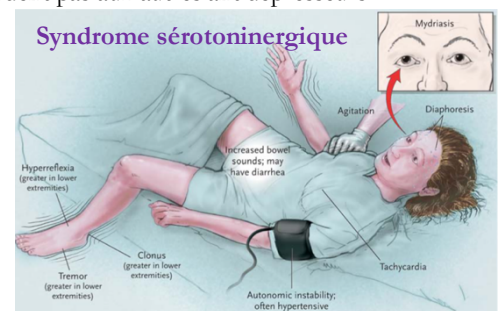
- Effets anti-muscariniques (sécheresse bouche, rétention urinaire, augmentation de la pression intra-oculaire, confusion mentale)
- Effets anti-histaminergiques (sédation)
- Effets anti-α-adrénériques (hypotension orthostatique)
- Arythmies graves avec des bloc AV à cause de l'interaction avec les canaux sodiques
- Prise de poids (multiples récepteurs)
- Dysfonctions sexuelles
- La toxicité aiguë (tentamen) :
 - Excitation, convulsions
 - Dépression respiratoire, coma
 - Arythmies



Le rôle postulé du Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) dans la dépression



- **Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine SSRI** (**Fluoxétine** (Fluctine®), **Paroxétine** (Deroxat®), **Sertraline** (Zoloft®), **Citalopram** (Seropram®), **Fluvoxamine** (Floxyfral®))
 - Moins d'effets indésirables que les **tricycliques**
 - → **Antidépresseurs en première ligne** !
 - Éventuellement moins de toxicité aiguë et donc de risques associés au suicide
 - **Effets secondaires** :
 - Anxiété, insomnie, céphalées
 - Troubles sexuels
 - Nausées, diarrhées, perte d'appétit
 - Syndrome de discontinuation sérotoninergique : irritabilité, nausées, sensation de chocs électriques, insomnies, sueurs profuses (pas une dépendance)
 - Inhibition des enzymes du P450 (**Fluoxétine**, **Paroxétine**, **Fluvoxamine**)
- **Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine-Noradrénaline SNRI** (**Duloxétine**, **Venlafaxine**)
 - Profil d'affinité pour l'inhibition de la recapture de la sérotonine identique aux **tricycliques**
 - Affinité plus faible pour les récepteurs muscariniques, H1 et adrénergiques que les **tricycliques**
 - → **Moins d'effets indésirables potentiels** !
 - **Effets indésirables** :
 - Profil similaire aux **SSRI** pour les **effets sérotoninergiques** (troubles gastro-intestinaux), et aux **tricycliques** pour les **effets noradrénergiques** (hypotension orthostatique)
- **Antidépresseurs sérotoninergiques et noradrénergiques** (**Mirtazapine**)
 - **Première ligne**
 - Pas de blocage de transporteurs, mais stimulation de la libération de sérotonine et effet noradrénergique
 - Effet sédatif (anti-H1) et prise de poids
 - Peu ou pas d'effet GI et sexuels
- **Antidépresseurs mélatoninergique** (**Agomélatine**)
 - **Première ligne**
 - ↗ libération de noradrénaline et dopamine spécifiquement dans le cortex frontal (pas d'effet sur les concentration extracellulaires de sérotonine)
 - Agoniste récepteurs MT1 et MT2, resynchronise les rythmes circadiens dans des modèles animaux
- **Inhibiteurs des MAO-A** (**Moclobémide**)
 - Inhibiteur compétitif et sélectif de MAO-A :
 - ↗ niveau des mono-amines dans le SNC
 - Interactions :
 - ↗ les effets des **amines sympathomimétiques** (tyramine, amphétamine)
 - La **tyramine** alimentaire est dégradée par la MAO de l'intestin et du foie, et elle s'accumule dans les terminaisons sympathiques, ce qui ↗ la libération d'adrénaline et de NA
 - Usage clinique :
 - Dépression, pas en première intention mais chez les patients qui ne répondent pas aux autres antidépresseurs
 - **Effets indésirables** :
 - Excitation du SNC (insomnie, tremblement, convulsions)
 - Hépatotoxicité
 - Crises hypertensives possibles
 - Interaction possible avec les aliments riches en **tyramine**
 - Risque ++ de **syndrome sérotoninergique** lorsque associé avec des antidépresseurs sérotoninergiques ou sérotoninergique/noradrénergique
 - → **CONTRE-INDICATION** !
 - CAVE aussi lorsque l'on passe d'un traitement à l'autre
- **Lithium**
 - Mécanismes :
 - Inhibition du métabolisme des pospho-inositides, qui est probablement liée à l'effet anti-maniaque/antidépresseur
 - Usage clinique (pas classé comme antidépresseur, mais comme stabilisateur de l'humeur) :
 - TT des phases aiguës et en prophylaxie à long terme de la maladie maniaco-dépressive
 - ↗ de l'effet antidépresseur (ajout lors d'une non réponse sur un TT antidépresseur dans une dépression unipolaire)
 - **Effets indésirables** (**marge thérapeutique étroite → dosage sanguin est obligatoire**) :
 - Tremblements
 - Nausées, diarrhées
 - Fatigue
 - Diabète insipide rénal (inhibition de la sécrétion de vasopressine)
 - Rétention sodée et œdèmes
 - Plus rarement :
 - Toxicité rénale (particulièrement aux taux sanguins élevés)
 - Arythmies
 - Intoxication (vomissement, diarrhée, tremblement, ataxie, coma, convulsion)



- Efficacité
 - Globalement, tous les antidépresseurs sont égaux en termes d'efficacité, mais il y a quand même des différences :
 - Notamment, pour les **tricycliques** on a une problématique due au fait que les doses efficaces sont supérieures aux doses initiales, et souvent aussi supérieures aux doses utilisées (dû aux effets secondaires)
 - Toxicité cardiaque, toxicité en surdosage : **tricycliques** utilisés maintenant rarement, surtout dans des cas de non-réponses aux autres antidépresseurs
 - Dans la comparaison de l'efficacité des antidépresseurs, problématique des études non-publiées. Si l'on résume les conclusions d'une méta-analyse des antidépresseurs, on constate que la **sertraline**, le **citalopram**, la **venlafaxine** et la **mirtazapine** semblent les plus efficaces ; de plus, ils ont un faible potentiel d'interaction avec les CYP450. Cependant, ces résultats ne sont pas gravés dans le marbre. On a des différences modérées, mais à défaut de mieux ces résultats peuvent être utilisés comme une première indication
 - ▶ Il est **important d'évaluer l'utilité d'un TT** antidépresseur au cas par cas ; on prescrit pour les **dépressions** d'intensité **moyenne** à **sévère**, mais **pas** en cas de **dépression légère**
 - Le **choix** d'un antidépresseur est notamment basé sur
 - Le risque d'effets secondaires, le risque d'interactions (si polymédication), le coût et la disponibilité, et les préférences du prescripteur
 - La réponse/échec à un TT antérieur, les comorbidités du patient, et ses préférences
 - **En première ligne** :
 - Profil limité d'effets secondaires : **SSRI**
 - Mais aussi : **agomélatine**, **bupropion**, **mirtazapine**, **trazodone**, **vortioxetine**
 - **SNRI** possible mais effets secondaires plus marqués
 - Psychiatrie : **TT à long terme**
 - **Dépression** :
 - TT de minimum 6 mois à dose adéquate
 - 6 mois **APRES** la rémission et non pas après le début du traitement
 - **Dépression récurrente** :
 - TT de 2-5 ans généralement à la même dose que la phase aiguë
 - **Schizophrénie** :
 - TT jusqu'à 1 an après une rémission complète d'un premier épisode aigu
 - TT jusqu'à 2 ans après la rémission complète d'un deuxième épisode aigu
 - Diagnostic de **schizophrénie avec des épisodes multiples et des symptômes résiduels** :
 - TT à très long terme
 - Risque de rechute chez des patients avec au moins 3 échecs thérapeutiques
 - TT d'au moins 2 ans recommandé
 - Réévaluation régulière nécessaire (effet thérapeutique, condition somatique...)
 - **Arrêt de TT** :
 - Signes de sevrage
 - Symptômes "grippaux", insomnie, irritabilité, paresthésies, troubles locomoteurs et/ou de concentration
 - Apparaissent en moyenne 5 jours après l'arrêt du TT
 - Diminution graduelle de la posologie
 - Sauf : **fluoxétine** (demi-vie longue) et **agomélatine** (demi-vie 2 heures)
 - Activité physique et santé mentale
 - Est associée à une meilleure santé mentale autant chez les personnes avec une dépression que sans dépression
 - Est plus bénéfique que le revenu ou la formation
 - Tous les types d'activité physiques sont associés à une meilleure santé mentale, avec la plus forte réduction trouvée pour les sports d'équipe, le cyclisme, l'aérobique et la gymnastique, pour des durées de 45 minutes et une fréquence de 3 à 5 fois par semaine (encore plus d'exercice n'est pas forcément bénéfique)
 - L'exercice induit une ↗ de facteurs trophiques (notamment BDNF)
 - Le lactate a possiblement un effet antidépresseur

Recherche translationnelle

Pas dans examen

- La dichotomie entre réductionnisme biologique et chapelles psychothérapeutiques est dépassée : elle permet donc la collaboration entre psychiatres psychothérapeutes et psychiatres biologiques
- La majorité des troubles psychiatriques se comprennent comme le fruit de l'interaction entre :
 - Vulnérabilité (à base biologique ou psychologique)
 - Facteurs de stress (psychologiques, biologiques ou sociaux)
- Cette base biologique reste très mal connue
- La quasi-totalité des traitements biologiques actuellement utilisés sont issus de la sérendipité
 - Observation par hasard d'un effet
- Plusieurs modèles explicatifs des troubles psychiatriques n'ont été construits qu'à postériori, sur la base de ces observations
 - Théorie de l'excès de dopamine dans la psychose
- Regroupement des troubles en syndromes souvent peu satisfaisants (schizophrénie), qui rassemblent probablement des patients souffrants de maladies différentes
- Délimitation floue entre les pathologies
- Incapacité à identifier précocement les troubles (détection précoce) de manière précise du fait du manque de biomarqueurs fiables

- Important de faire converger recherche clinique et neurosciences de bas, de renforcer la collaboration entre cliniciens et chercheurs en neurosciences fondamentales de manière à promouvoir :
 - Une meilleure connaissance des mécanismes qui sous-tendent les maladies psychiatriques
 - Des classifications qui reposent sur des bases plus solides
 - La découverte de traitements plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des patient
- ▶ Crée un contexte dans lequel compétences cliniques et neuroscientifiques peuvent entrer en synergie
- ▶ Permet un va et vient entre modèle animal et humain qui facilite l'exploration des mécanismes neurobiologiques
- ▶ Est l'une des stratégies essentielles pour améliorer les traitements en psychiatrie contemporaine

Changement climatique et santé mentale

Pas dans examen